PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI ANESTESIOLOGI
DAN TERAPI INTENSIF

RSUD dr. LOEKMONO HADI

Sehat Anda, Senyum Kita

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. LOEKMONO HADI

KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 ☏ (0291) 444001 🖷 (0291) 438195
Email : rsuddrloekmonohadi@kuduskab.go.id ; rsudkudus@yahoo.co.id
Website : www.rsuddrloekmonohadi.kuduskab.go.id
RSUD dr. LOEKMONO HADI
Sehat Anda, Senyum Kita

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

NOMOR : 400.7.3.4/321/2026

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Menimbang :

a. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah unit fungsional di rumah sakit yang bertugas melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan pembiusan pasien perioperatif, resusitasi, pengelolaan nyeri, dan perawatan intensif bagi pasien kritis secara professional.

b. Bahwa tujuan Pengaturan pedoman pelayanan Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan keselamatan pasien.

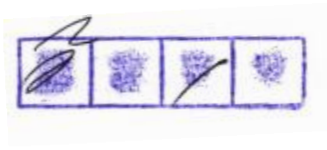
c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas, maka diperlukan buku Pedoman Pelayanan Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi

Mengingat :

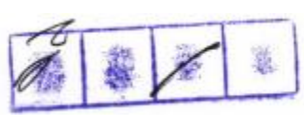
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);



4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan ICU;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1541 Tahun 2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Anestesiologi dan Terapi Intensif;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 24);



14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Anestesiologi dan Terapi Intensif

KETIGA : Dalam pelaksanaan Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;

KEEMPAT : Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana dalam lampiran;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pembuatan keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan untuk perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Februari 2026

Plt. DIREKTUR RSUD
dr. LOEKMONO HADI
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RSUD dr. LOEKMONO HADI

MUSTIKO WIBOWO

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah dr.Loekmono Hadi
Nomor : 400.7.3.4/321/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 bagian H, ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, salah satunya adalah Intensive Care Unit (ICU).

Intensive Care Unit (ICU) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang menderita penyakit akut, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensi mengancam nyawa dengan prognosis yang diharapkan masih reversible. ICU menyediakan kemampuan dan sarana, prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital dengan menggunakan ketrampilan staf medis, perawat dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus sebagai rumah sakit pemerintah Kelas B Pendidikan memiliki fungsi sebagai rumah sakit rujukan regional yang wajib menyelenggarakan pelayanan spesialistik dan subspesialistik, termasuk pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif. Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus terdiri dari layanan General ICU (ICU umum), Intensif Care cardiac Unit (ICCU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pelayanan Anestesiologi terintegrasi dan Pelayanan

Anestesi di luar Instalasi Bedah Sentral yang biasa disebut Non Operating Room Anastesi (NORA). NORA meliputi pelayanan sedasi di Cathlab, MRI, CT Scan, ECT, Radioterapi, Code Blue, Pelayanan Nyeri, Poli Anestesi.

Sebagai unit pelayanan intensif yang memberikan pelayanan Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, bermutu, serta berpusat pada pasien dan keluarga (*patient and family centered care*). Pelayanan tersebut meliputi stabilisasi pasien, pemantauan hemodinamik, dukungan fungsi organ, tindakan resusitasi, tata laksana kegawatdaruratan pasien dewasa, neonatal dan pediatric, pelayanan kolaboratif multidisiplin, serta pelayanan rujukan sesuai jejaring pelayanan untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Pedoman pelayanan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan rumah sakit, standar profesi, praktik klinis berbasis bukti (*evidence-based practice*), serta prinsip peningkatan mutu dan keselamatan pasien sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan intensif yang optimal di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai pedoman bagi seluruh tenaga kesehatan di Pelayanan Anestesiologi dan terapi intensif RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dalam menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, aman, efektif, efisien, terintegrasi, berorientasi pada keselamatan pasien, serta sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan**.**

2. Tujuan Khusus

a. Mewujudkan Tata kelola Klinis yang Standar : Mengimplementasikan tata laksana anestesiologi dan terapi intensif yang komprehensif pada anak dan neonatus kritis sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1541/2022.

b. Menjamin Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) : Menyediakan standardisasi alur kerja, distribusi kompetensi SDM, penataan sarana prasarana, serta pemanfaatan sistem

informasi guna meminimalkan risiko kejadian tidak diharapkan (KTD).

C. Definisi

1. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
2. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi
3. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya Kesehatan
5. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.

8. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan
9. Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Kesehatan
10. Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif adalah tindakan medis yang dilakukan melalui pendekatan tim sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Tim pengelola pelayanan anestesiologi dan terapi intensif dipimpin oleh dokter spesialis anestesiologi dengan anggota dan/atau dokter peserta program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan/atau dokter lain dan perawat anestesia/ perawat. Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif mencakup tindakan anestesia (pra anestesia, intra anestesia dan pasca anestesia) serta pelayanan lain sesuai bidang anestesiologi seperti pelayanan kritis, gawat darurat, penatalaksanaan nyeri, dan lain-lain.
11. *Intensive Care Unit* (ICU) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri (instalasi di bawah direktur pelayanan), dengan staf yang terlatih serta perlengkapan khusus, yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa, dengan prognosis yang masih dapat diharapkan. Berdasarkan karakteristik pelayanan ICU terdiri dari ICu dewasa, PICU NICU dan ICCU.
12. *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU) adalah unit perawatan intensif yang memberikan pelayanan kepada bayi dan anak (di luar periode neonatal) yang mengalami kondisi kritis dan memerlukan pemantauan, observasi, serta terapi intensif secara terus-menerus. PICU merupakan bagian dari pelayanan intensive care di rumah sakit
13. *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah unit perawatan intensif yang memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir (neonatus) yang memerlukan perawatan khusus dan intensif, seperti bayi prematur, bayi berat lahir rendah, gangguan

pernapasan, kelainan kongenital, atau kondisi kritis lainnya yang memerlukan pemantauan dan terapi intensif.

14. *Intensive Coronary Care Unit* (ICCU) adalah unit perawatan intensif yang memberikan pelayanan kepada pasien dengan penyakit kardiovaskular kritis, terutama penyakit jantung koroner akut, infark miokard akut, aritmia berat, gagal jantung akut, dan keadaan gawat darurat jantung lainnya yang memerlukan pemantauan serta terapi intensif secara berkesinambungan
15. Anestesi di luar kamar operasi atau *Non Operating Room Anesthesia* (NORA) merupakan pemberian anestesi atau sedasi di luar kamar operasi pada pasien yang menjalani prosedur yang menyakitkan atau membuat tidak nyaman. Selanjutnya tindakan anestesi di luar kamar operasi ini disebut sedasi prosedural. Termasuk didalamnya meliputi : radiologi diagnostik dan intervensional, endoskopi gastrointestinal, tindakan diagnostik atau terapeutik minimal invasive, kateterisasi jantung, terutama pada anak, prosedur kedokteran gigi, terapi psikiatri, seperti terapi kejang listrik (*electroconvulsive therapy*).
16. Pelayanan anestesia peri-operatif merupakan pelayanan anestesia yang mengevaluasi, memantau dan mengelola pasien pra, intra dan pasca anestesia serta terapi intensif dan pengelolaan nyeri berdasarkan keilmuan yang multidisiplin, terdiri dari pra anaestesi, intra anestesi dan post anestesi

D. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan pada Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lingkup Pasien dan Batasan Usia
    a. General ICU merupakan pelayanan Intensif secara umum untuk pasien dewasa > 18 tahun untuk kasus pasien kritis yang memerlukan bantuan nafas, obat – obatan vasopressor, dan pengawasan intensif.
    b. Unit NICU (Neonatal Intensive Care Unit) yaitu pelayanan perawatan intensif (Level III) bagi bayi baru lahir berisiko tinggi yang mengalami gangguan fungsi organ vital dengan batasan usia 0 hingga 28 hari pasca-lahir (termasuk bayi

prematuritas ekstrem atau dengan berat badan lahir amat sangat rendah).

c. Unit Peristi (Neonatologi) yaitu pelayanan perawatan semi-intensif (Intermediate Care / Level II) dan perawatan risiko rendah (Low Care / Level I) bagi neonatus yang memerlukan pemantauan khusus, terapi sinar, rehabilitasi laktasi, atau masa transisi pemulihan dari kondisi kritis sebelum diizinkan pulang.

d. Unit PICU (Pediatric Intensive Care Unit) yaitu pelayanan perawatan intensif bagi pasien anak yang mengalami sakit kritis atau kegagalan fungsi organ vital yang mengancam nyawa, dengan batasan usia di atas 28 hari sampai dengan menjelang usia 18 tahun.

e. Unit anastesi perioperatif yaitu pelayanan anestesi untuk kasus operasi di Instalasi Bedah Sentral.

f. Unit ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) yaitu palayanan perawatan intensif bagi pasien dengan penyakit jantung yang memerlukan terapi intensif dan pemantauan.

g. Unit Anestesi di Luar IBS (Non Operating Room Anestesi/ NORA) yaitu pelayanan anestesi yang meliputi pelayanan kegawatan Code Blue, Manejemen Nyeri, Sedasi di Luar IBS (CT Scan, Cathlab, MRI, ECT dan Radioterapi).

2. Berdasarkan Jenis Intervensi Medis dan Tata Laksana Klinis

a. Tindakan resusitasi dan stabilisasi yang menangani awal kegawatdaruratan sistem pernapasan, hemodinamik, dan neurologis secara cepat, baik pada kasus rujukan internal (Kamar Bersalin/PONEK, Kamar Operasi, IGD) maupun rujukan eksternal dari fasilitas kesehatan lain.

b. Bantuan Hidup Lanjut (Life Support) dengan pengelolaan jalan napas dan ventilasi mekanik invasif maupun non-invasif (seperti penggunaan mesin Ventilator, Continuous Positive Airway Pressure / CPAP, High Flow Nasal Cannula / HFNC), serta dukungan inotropik.

c. Pemantauan kontinu dengan observasi ketat parameter fisiologis vital pasien melalui bedside monitor (frekuensi jantung, saturasi oksigen, tekanan darah, suhu tubuh) selama 24 jam.

d. Terapi nutrisi intensif dan metabolik dengan pemberian nutrisi parenteral total maupun enteral yang disesuaikan dengan kebutuhan metabolik spesifik bayi prematur dan anak kritis, berkolaborasi dengan ahli gizi.

3. Berdasarkan Lingkup Jejaring Pelayanan dan Administrasi Informasi
   a. Pelayanan SISRUTE yaitu pelaksanaan komunikasi praterima pasien dan koordinasi rujukan antar-fasilitas kesehatan di bawah skema jejaring pengampuan KIA, TB, HIV AIDS, STEMI, Stroke, Gagal ginjal demi memotong waktu keterlambatan penanganan.
   b. Pemanfaatan Rekam Medis Elektronik (RME), interkoneksi laboratorium (LIS), serta pelaporan indikator mutu klinis unit intensif secara periodik ke dalam sistem informasi rumah sakit.
   c. Pelayanan asuhan yang berpusat pada keluarga (Family-Centered Care), yang meliputi konseling medis, edukasi metode kanguru (Kangaroo Mother Care) di PICU NICU, pelayanan paliatif, fisioterapi, dan edukasi kepada keluarga di ICU, IBS dan NORA.

BAB II
STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi sumber daya manusia

Pelayanan di Instalasi anestesiologi dan terapi intensif dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga yang dipersyaratkan, serta memperoleh kewenangan klinis (clinical privilege) sesuai dengan penugasan klinis di Rumah Sakit.

1. Pendidikan

a. Tenaga Medis terdiri dari
b. Kepala Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah dokter Spesialis Anestesi Konsultan Intensive Care
c. Dokter spesialis pendukung adalah serta dokter spesialis lain yang tergabung dalam tim perawatan pasien sesuai kasus
d. Dokter Umum berpendidikan dokter umum jaga siang dan malam.

2. Tenaga Keperawatan

Adapun tenaga keperawatan di ICU, ICCU, PICU NICU, NORA dan anestesi terintergarasi terdiri dari

a. Kepala ruang keperawatan berpendidikan Sarjana Keperawatan + Profesi Ners (S.Kep., Ns.) atau Magister Keperawatan (M.Kep)
b. Wakil kepala Ruang Berpendidikan Sarjana Keperawatan + Profesi Ners (S.Kep.,Ns.) atau D3 Keperawatan dengan pengalaman kerja yang memadai lebih dari 5 tahun
c. Perawat Penanggung Jawab Pelayanan (PPJP) berpendidikan Sarjana Keperawatan + Profesi Ners (S.Kep., Ns.) atau D3 Keperawatan.
d. Perawat Asociet1 (PA 1)/Perawat Pelaksana 1 adalah berpendidikan D3 Keperawatan atau Sarjana Keperawatan + Profesi Ners (S.Kep., Ns.).

e. Perawat Asociet2 (PA 2) / Perawat Pelaksana 2 adalah berpendidikan D3 Keperawatan atau Sarjana Keperawatan + Profesi Ners (S.Kep., Ns.).

f. Tenaga Administrasi adalah minimal lulusan SMA/SMK Sederajat, D3 Manajemen, D3 Rekam Medis, atau D3 Komputer/Informatika.

g. Penata Anestesi Adalah berpendidikan penata anestesi D4 atau perawat dengan pelatihan anestesi.

3. Kompetensi

a. Tenaga Medis terdiri dari

1) Kepala Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensive Adalah seorang dokter Anestesi Konsultan Intensive Care yang kompetensinya adalah

a) Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.

b) Menguasai manajemen tata laksana pasien critically ill (dewasa, anak, dan neonatus), pengelolaan jalan napas lanjut (advanced airway management), serta terapi sedasi/analgesia intensif.

c) Sertifikat Pelatihan Tata Laksana Terapi Intensif/Care Unit.

d) Sertifikat Pelatihan Manajemen/Manajerial Kepemimpinan Rumah Sakit.

e) Sertifikat Advanced Cardiac Life Support (ACLS) dan/atau Pediatric Advanced Life Support (PALS).

2) Dokter spesialis pendukung adalah dokter Spesialis Anak (Sp.A), Spesialis Jantung, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Saraf, Spesialis Rehab Medik, Spesialis Gizi Klinik, sesuai jadwal serta dokter spesialis lain sesuai kasus

3) Dokter Umum yang memiliki STR dan SIP aktif, sertifikat resusitasi yang diakui (FCCS, ATLS, ACLS, APLS/ALS, Resusitasi Neonatus) dan bertugas secara *shift* 24 jam di bawah supervisi DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan).

b. Tenaga Keperawatan

Tenaga Keperawatan di Instalasi Anestesi dan Terapi Intensif terdiri dari:

1) Kepala ruang keperawatan adalah memiliki STR dan SIPP aktif dengan kualifikasi minimal Perawat Klinis (PK) III atau IV. Memiliki sertifikat pelatihan manajemen keperawatan / kepala ruangan, sertifikat pelatihan keperawatan intensif ICU/NICU/PICU terakreditasi kemenkes (jangka waktu minimal 3–6 bulan), sertifikat Resusitasi Neonatus (NRP/STABLE), pelatihan PONEK, serta sertifikat *Basic/Advanced Cardiac Life Support* (BLS/ACLS).
2) Wakil kepala ruangan memiliki STR dan SIPP aktif dengan jenjang kualifikasi Perawat Klinis (PK) III. memiliki sertifikat pelatihan keperawatan ICU, NICU/PICU tingkat lanjut, sertifikat resusitasi neonatus (NRP/STABLE), sertifikat pelatihan kepemimpinan dan manajemen keperawatan dasar, serta pelatihan PONEK.
3) Perawat Penanggung Jawab Pelayanan (PPJP) / Perawat Primer memiliki STR dan SIPP aktif dengan jenjang kualifikasi Perawat Klinis (PK) II atau PK III. Berpengalaman dan tersertifikasi dalam pelatihan keperawatan intensif dewasa dan neonatus (NICU) atau Anak (PICU) terakreditasi. Wajib memiliki kompetensi resusitasi neonatus (NRP/STABLE), manajemen bayi berat lahir rendah (BBLR), Perawatan metode kanguru (PMK), serta sertifikat keselamatan pasien dan pencegahan pengendalian infeksi (PPI).
4) Perawat Asociet1 (PA 1)/Perawat Pelaksana 1 memiliki STR dan SIPP aktif dengan jenjang kualifikasi Perawat Klinis (PK) II. Memiliki sertifikat pelatihan intensif dasar keperawatan , sertifikat resusitasi neonatus (NRP Dasar), sertifikat Bantuan Hidup Dasar (BHD/BLS), serta pelatihan PPI dan manajemen vaskuler/terapi infus.
5) Perawat Asociet2 (PA 2) / Perawat Pelaksana 2 memiliki STR dan SIPP aktif dengan jenjang kualifikasi perawat klinis (PK) I (Tahap Pra-PK/Orientasi). Memiliki sertifikat

bantuan hidup dasar (BHD/BLS), telah menyelesaikan masa program orientasi pelayanan di unit NICU/PICU/Peristi, serta menguasai dasar-dasar pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan keselamatan pasien.

6) Tenaga Administrasi adalah Terampil dalam pengoperasian komputer dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Memiliki kompetensi pelayanan prima (*service excellence*), sertifikat/pelatihan tata kelola kearsipan, serta pemahaman terkait prosedur administrasi penjaminan pasien (klaim BPJS Kesehatan maupun asuransi swasta).

7) Penata Anestesi adalah berpendidikan penata anestesi D4 atau perawat dengan pelatihan anestesi bersertifikat. Adapun pelatihan pelatihan yang wajib dimiliki antara lain:

   a) *Basic Life Support* (BLS) bagi seluruh perawat dan penata
   b) *Pediatric Advanced Life Support* (PALS)/*Advanced Pediatric Life Support* (APLS), Pelatihan Resusitasi Neonatal, Pelatihan PICU/NICU, PONEK bagi perawat PICU NICU
   c) Pelatihan PPI, K3, SKP bagi seluruh perawat dan penata
   d) Pelatihan Penata Anestesi bagi Penata Anestesi
   e) Pelatihan ICU Dasar atau ICU Komprehensif, Pelatihan ventilator, perawatan paliatif bagi perawat ICU dan ICCU

c. Tim Multidisiplin

Kerjasama multidisiplin dalam pelayanan serta dasar pengelolaan di lingkungan Anestesiologi dan Terapi Intensive adalah pendekatan multidisiplin dari beberapa ilmu terkait yang dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan bidang keahliannya dan bekerjasama dalam tim yang dipimpin dokter intensivis/ dokter spesialis anestesi (KIC) sebagai kepala ICU.

Tim intensive care, anastesi perioperatif, PICU NICU, ICCU, NORA minimal terdiri dari :

- Intensivis/spesialis anestesi yang berkompeten dalam ilmu kedokteran intensive care (KIC) sesuai dengan level ICU
- Dokter spesialis lainnya yang terlibat dalam pelayanan pasien
- Perawat intensive care
- Ahli farmasi klinik
- Dietisien/ahli nutrisi
- Fisioterapis
- Radiografer
- Hemodialisis
- Penata Anetesi
- Analis dan tenaga pendukung lainnya.

B. Pola ketenagaan

1. Jumlah SDM
   a. Kepala Instalasi ICU
   b. Dokter Spesialis
   c. Dokter Umum
   d. Perawat Anestesi
   e. Perawat Intensive ICU, ICCU, PICU/NICU
2. Sistem Kerja
   a. Pengaturan Jaga
      Jam Dinas :
      - Dinas Pagi : 07.00 – 14.00
      - Dinas Sore : 14..00 – 21.00
      - Dinas malam : 21.00 – 07.00
   b. Dokter anestesi hadir tiap hari pada jam kerja (pagi).
   c. Dokter jaga 24 jam tiap shift 1 orang dokter umum.
   d. Perawat pelaksana 24 jam dibagi menjadi 3 shift (pagi : 6, siang : 6, malam : 6), tiap shiftt harus ada minimal 1 orang sebagai ketua tim, sebagai penanggung jawab shift .
   e. Tenaga administrasi hanya ada pada shift pagi, saat siang dan malam dirangkap oleh perawat.
   f. Tenaga kebersihan melaksanakan 3 shift (pagi, siang dan malam)

3. Kebutuhan Tenaga ICU

Berdasarkan Keputusan menteri kesehatan nomor 1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan intensive care unit (ICU) di rumah sakit Standar tenaga keperawatan di rumah sakit untuk pasien yang terpasang ventilator 1 :1 sedangkan pada pasien ICU yang tidak terpasang ventilator 1 : 2.

Kebutuhan ideal bila tenaga keperawatan di ruang ICU RSUD dr Loekmono hadi kudus dengan kapasitas 20 Bed dan BOR 80%, maka dapat di hitung pasien rata rata sebanyak 16 pasien, dengan perbandinagan 1:2 (satu perawat 2 pasien) maka kebutuhan tenaga perawatan per shift ialah : 16: 2 = 8 perawat, Jumlah kebutuhan perhari dalam 3 shift adalah 3x8 = 24 perawat, di tambahkan OFF day (Multiplayer =1,8) = 24 X 1,8 = 43,2. Jadi total kebutuhan perawat ideal di ruang ICU sebanyak 44 perawat

C. Pengembangan SDM

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta mutu pelayanan pendidikan klinik di Rumah Sakit Pendidikan. Seluruh anggota Komite Koordinasi Pendidikan dan tenaga pendukung wajib mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta regulasi yang berlaku

1. Pelatihan

Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif merupakan pelayanan yang kompleks, berisiko tinggi, dan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi, kewenangan klinis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keselamatan petugas,ICU,PICU-NICU tenaga kesehatan yang bertugas di Instalasi Anestesiologi, Intensive Care Unit (ICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) dan NORA (Non Operating Room Anastesi) harus memperoleh pendidikan dan pelatihan secara terencana, berkesinambungan, dan terdokumentasi.

Program Pelatihan Standar Sumber Daya Manusia Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi bagi Kepala Instalasi, dokter spesialis, dokter umum, perawat, penata anestesi, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kewenangan klinis. Program ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, serta mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien, sekaligus mendukung tata kelola klinis, peningkatan mutu

Standar pelatihan kualifikasi wajib maupun pengembangan yang di miliki tenaga medis dan keperawatan serta nom medis di Instalasi Anestesiologi, Intensive Care Unit (ICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) dan NORA (Non Operating Room Anastesi) adalah :

Tabel 2.1

Pelatihan

No	Jabatan	Pelatihan Wajib
	Seluruh Staff	• Orientasi rumah sakit • Keselamatan Pasien (Patient Safety) • Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) • Bantuan Hidup Dasar (BLS) • K3 Rumah Sakit • Fire Safety • Code Blue • Komunikasi Efektif (SBAR) • Etika dan Hukum Kesehatan • Manajemen Risiko • Pelayanan Berfokus pada Pasien
	Kepala Instalasi ICU/PICU-NICU/ICCU/Anastesi	• Leadership • Manajemen Pelayanan Intensif • Manajemen Risiko • Keselamatan Pasien • PPI • Akreditasi RS • Clinical Governance • Manajemen SDM • Emergency & Disaster Management
	Dokter Intensivist/Spesialis	• ACLS • ATLS (sesuai kebutuhan) • Critical Care Update

	Anastesi/Anak/ Jantung	• Ventilator Management • Hemodynamic Monitoring • Sedasi & Analgesia • Sepsis Update • PPI • Patient Safety
	Dokter Umum ICU/PICU-NICU	• Basic Critical Care Course (BCCC) • ACLS • Ventilator Dasar • Airway Management • ECG • BLS • PPI • Keselamatan Pasien • Komunikasi Efektif • PALS • NRP • Neonatal Emergency • Pediatric Critical Care Basic • Ventilator Neonatal/Pediatrik
	Perawat ICU	• Pelatihan Keperawatan Intensif ICU • ACLS/BLS • Ventilator Management • CRRT dasar • Hemodynamic Monitoring • Infusion Pump • Syringe Pump • PPI • Patient Safety
	Perawat PICU-NICU	• Pelatihan PICU • PALS • Ventilator Pediatrik • Hemodynamic Anak • Nutrisi Anak Kritis • Ventilator Pediatrik dan neonatal
	Perawat ICCU	• Basic ECG • Advanced ECG • ACLS • Hemodynamic Monitoring • STEMI Management • Cardiac Emergency
	Penata Anastesi	• Pelatihan Penatalaksanaan Anestesi dan Sedasi • Airway Management • Difficult Airway • BLS • ACLS • Patient Safety

2. Program pelatihan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan anestesiologi dan terapi intensif yang aman, efektif, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien, Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif menyelenggarakan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara terencana, berkesinambungan, dan terdokumentasi. Program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kewenangan klinis, hasil evaluasi kompetensi, indikator mutu, serta hasil manajemen risiko.

a. Program pelatihan bertujuan untuk:
   1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional seluruh tenaga kesehatan.
   2) Memastikan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan lingkup kewenangan klinis.
   3) Mendukung penerapan budaya keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan.
   4) Memenuhi persyaratan kredensial, rekredensial, serta standar akreditasi rumah sakit.
   5) Mengembangkan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang anestesiologi dan terapi intensif.

b. Pelatihan Orientasi

   Dilaksanakan bagi seluruh pegawai baru dan pegawai yang dimutasi ke Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif, meliputi:
   1) Orientasi Rumah Sakit.
   2) Orientasi Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif.
   3) Orientasi ICU/PICU/NICU/ICCU sesuai unit penempatan.
   4) Pengenalan kebijakan, SPO, dan kewenangan klinis.

c. Pelatihan Wajib

   Diikuti oleh seluruh tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan, meliputi:
   1) Keselamatan Pasien (Patient Safety).
   2) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
   3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

4) Bantuan Hidup Dasar (BLS).
5) Code Blue.
6) Fire Safety.
7) Manajemen Risiko.
8) Komunikasi Efektif (SBAR).
9) Disaster Management.

d. Pelatihan Kompetensi Klinis

Disesuaikan dengan profesi dan unit pelayanan, antara lain:

1) Ventilator Management.
2) Airway Management.
3) Hemodynamic Monitoring.
4) Sedasi dan Analgesia.
5) Advanced Cardiac Life Support (ACLS).
6) Pediatric Advanced Life Support (PALS).
7) Neonatal Resuscitation Program (NRP).
8) Pelatihan Keperawatan Intensif ICU.
9) Pelatihan PICU.
10) Pelatihan NICU.
11) Pelatihan ICCU.
12) Pelatihan Penatalaksanaan Anestesi.
13) Pelatihan Manajemen Nyeri.
14) Pelatihan Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) (sesuai layanan rumah sakit).

e. Pendidikan Berkelanjutan (Continuing Professional Development)

Dilaksanakan dalam bentuk:

1) In-house training.
2) Seminar ilmiah.
3) Workshop.
4) Simposium.
5) Webinar.
6) Telaah jurnal (Journal Reading).
7) Presentasi kasus.
8) Morbidity and Mortality Conference (M&M).
9) Simulasi kegawatdaruratan.

f. Evaluasi Kompetensi

Evaluasi dilakukan melalui:

1) Penilaian kompetensi.
2) Kredensial dan rekredensial.
3) Audit klinis.
4) Penilaian kinerja.
5) Evaluasi hasil pelatihan.
6) Monitoring indikator mutu dan keselamatan pasien.

Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rencana pelatihan tahun berikutnya serta pengembangan kompetensi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

g. Ketentuan Pelaksanaan
1) Program pelatihan disusun setiap tahun oleh Kepala Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif bersama Unit Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit.
2) Seluruh kegiatan pelatihan didokumentasikan sebagai bagian dari pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan.
3) Setiap tenaga kesehatan wajib memenuhi pelatihan sesuai jabatan, kewenangan klinis, dan unit kerja.
4) Rumah sakit memfasilitasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal maupun eksternal sesuai kebutuhan pelayanan dan kemampuan rumah sakit.
5) Evaluasi efektivitas pelatihan dilakukan secara berkala untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan profesionalisme tenaga kesehatan.

3. Sertifikat

Sertifikasi tenaga kesehatan di Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan klinis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis sertifikasi yang diperlukan meliputi:

a. Sertifikasi Umum
    1) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai profesi masing-masing.
    2) Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan yang berlaku.
    3) Sertifikat orientasi rumah sakit dan orientasi unit kerja.
    4) Sertifikat pelatihan Keselamatan Pasien (Patient Safety).
    5) Sertifikat Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
    6) Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
    7) Sertifikat Bantuan Hidup Dasar (BLS).
b. Sertifikasi Kompetensi Klinis
    1) Sertifikat Advanced Cardiac Life Support (ACLS) bagi dokter dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan.
    2) Sertifikat Pediatric Advanced Life Support (PALS) bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan PICU.
    3) Sertifikat Neonatal Resuscitation Program (NRP) bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan NICU.
    4) Sertifikat pelatihan Basic Critical Care/Intensive Care sesuai kewenangan dan area pelayanan.
    5) Sertifikat Ventilator Management.
    6) Sertifikat Airway Management.
    7) Sertifikat Hemodynamic Monitoring.
    8) Sertifikat Sedasi dan Analgesia.
    9) Sertifikat Penatalaksanaan Anestesi dan Sedasi bagi penata anestesi sesuai kompetensi.
c. Sertifikasi Profesional dan Pengembangan Berkelanjutan
    1) Sertifikat kegiatan Continuing Professional Development (CPD) sesuai ketentuan organisasi profesi.
    2) Sertifikat seminar, workshop, pelatihan, dan kegiatan ilmiah terkait anestesiologi dan terapi intensif.
    3) Sertifikat pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi Kepala Instalasi atau pejabat struktural.

Masa berlaku sertifikat mengikuti ketentuan lembaga penerbit sertifikat, organisasi profesi, dan regulasi yang berlaku. Rumah sakit melakukan pemantauan masa berlaku sertifikasi melalui unit terkait dan memastikan setiap tenaga kesehatan

yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi yang masih aktif melalui proses kredensial dan rekredensial.

BAB III
STANDAR FASILITAS DAN SARANA

A. Sarana dan Prasarana

1. Umum

Sarana dan prasarana Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif disediakan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan yang aman, efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan rumah sakit. Seluruh fasilitas dirancang untuk menunjang pelayanan pasien kritis selama 24 jam, memudahkan koordinasi antar profesi, serta menjamin keselamatan pasien dan petugas.

2. Ruang Kerja

Berdasarkan pedoman pengorganisasian, ruang pelayanan meliputi:

a. Ruang ICU-HCU : memiliki 20 tempat tidur terdiri dari 2 ruang isolasi tekanan negatif, 1 ruang isolasi tekanan positif, 2 ruang VIP, dan 15 tempat tidur terbuka.
b. Ruang PICU dengan 7 tempat tidur, NICU terdiri dari 9 tempat tidur dan Peristi terdiri dari 5 tempat tidur
c. Ruang ICCU memiliki 5 tempat tidur
d. Ruang Anestesi perioperatif / IBS terdiri dari 8 kamar operasi
e. Ruang NORA terdiri dari :
    1) Pelayanan kegawatan (code blue)
    2) Sedasi di ruang cathlab, radiologi, bangsal jiwa, radioterapi
    3) Poli nyeri dan poli anestesi

3. Peralatan Fasilitas Pendukung

Peralatan pelayanan yang tersedia meliputi antara lain:

a. ICU/PICU NICU/ICCU
    1) Tempat tidur elektrik pasien.
    2) Ventilator mekanik.
    3) Bed Side Monitor (BSM).
    4) Suction sentral.

5) Oksigen sentral.
6) Defibrillator (DC Shock).
7) Mesin ECG.
8) Incubator
9) Infant warmer
10) Infusion Pump.
11) Syringe Pump.
12) Troli emergensi.
13) Kasur dekubitus.
14) Blood Warmer.
15) Bag Valve Mask.
16) Resusitator dewasa, anak, dan bayi.
17) Laringoskop dewasa, anak, dan bayi.
18) Mesin dialisis.
19) Echocardiography.
20) Monitor tekanan darah invasif.
21) Monitor Central Venous Pressure (CVP).
22) Ventilator dan monitor transport pasien.
23) Manometer oksigen portable.

b. Anestesi Perioperatif
1) Tempat tidur operasi
2) Mesin Anestesi
3) Bed Side Monitor (BSM).
4) Suction sentral.
5) Oksigen sentral.
6) Defibrillator (DC Shock).
7) Incubator
8) Infant warmer
9) Infusion Pump.
10) Syringe Pump.
11) Troli emergensi.
12) Obat-obat anestesi dan emergency
13) Blood Warmer.
14) Bag Valve Mask.
15) Resusitator dewasa, anak, dan bayi.
16) Laringoskop dewasa, anak, dan bayi.

c. NORA

1) Tempat tidur pasien
2) Mesin Anestesi
3) Bed Side Monitor (BSM).
4) Suction sentral.
5) Oksigen sentral.
6) Defibrillator (DC Shock).
7) Incubator
8) Infant warmer
9) Infusion Pump.
10) Syringe Pump.
11) Troli emergensi.
12) Obat-obat anestesi dan emergency
13) Blood Warmer.
14) Bag Valve Mask.
15) Resusitator dewasa, anak, dan bayi.
16) Laringoskop dewasa, anak, dan bayi.
17) USG untuk poli nyeri
18) Radio Frequency untuk poli nyeri
19) Tas emergency untuk code blue

Jumlah masing-masing peralatan disesuaikan dengan daftar inventaris yang ditetapkan rumah sakit dan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan pelayanan.

4. Pemeliharaan Sarana

Pemeliharaan yang dimaksud adalah suatu proses bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kelayakan fungsi, dan keamanan alat pendidikan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan anestesi dan terapi intensif. Ruang lingkup pemeliharaan meliputi: Sarana prasarana bangunan dan Alat-alat medis dan non medis

a. Jadwal Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan dijadwalkan rutin setahun sekali oleh Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPSRS) atau insidental bila terjadi kerusakan. Pemeliharaan sarana prasarana ruang pelayanan dilakukan rutin setahun sekali oleh petugas yang terkait, atau insidental bila terjadi kerusakan untuk dilaporkan ke Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPSRS).

1) Pemeliharaan Preventif

Kepala Instalasi Anestesi dan Terapi Intensif menyusun jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana setiap 1 tahun sekali. Penanggung jawab alat melakukan pengecekan kebersihan, fungsi dasar, dan kelengkapan setiap selesai digunakan.

Tim IPRS melakukan service berkala: pembersihan, pelumasan, pengecekan kelistrikan, dan kalibrasi. Hasil pemeliharaan dicatat dalam Formulir Kartu Pemeliharaan Alat.

2) Pemeliharaan Korektif

Jika ditemukan kerusakan, pengguna wajib lapor ke Kepala Ruang maksimal 1x24 jam melalui Formulir Laporan Kerusakan.

Kepala Ruang berkoordinasi dengan IPRS untuk analisa dan perbaikan. Jika tidak dapat diperbaiki di internal, diajukan ke vendor/rekanan.

Alat yang sudah diperbaiki dilakukan uji fungsi oleh Kepala Ruang sebelum digunakan kembali.

b. Sistem Pemeliharaan

Kepala ruang : Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pemeliharaan alat pendidikan. Penanggung Jawab Alat/Unit: Melakukan pencatatan penggunaan dan melaporkan kerusakan.

IPSRS : Melakukan pemeliharaan teknis dan kalibrasi sesuai jadwal.

Kepala Instalasi anestesi dan terapi intensif: Menyetujui anggaran pemeliharaan.

Inventaris Alat Pendidikan dicatat oleh Kepala ruang dan diperbarui tiap tahun. Kartu Pemeliharaan: 1 kartu untuk 1 alat, berisi riwayat pemeliharaan. Laporan Pemeliharaan dilaporkan ke bagian Rumah Tangga setiap 1 tahun.

BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN

A. Alur Pelayanan

1. ICU

ALUR PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

a. Identifikasi dan Seleksi Pasien ICU

Pasien yang memerlukan perawatan di ICU merupakan pasien dengan kondisi kritis, berisiko mengalami kegagalan fungsi organ, membutuhkan pemantauan ketat, dukungan organ, atau tindakan terapi intensif yang tidak dapat dilakukan di ruang perawatan biasa. Pasien dapat berasal dari:

1) Instalasi Gawat Darurat (IGD).
2) Kamar Operasi.
3) Ruang Rawat Inap.
4) Ruang Perawatan Khusus (HCU/ICCU/PICU/NICU sesuai kebutuhan).
5) Rujukan dari fasilitas kesehatan lain.

Kriteria masuk ICU ditentukan berdasarkan kondisi klinis pasien, kebutuhan monitoring, kebutuhan ventilasi mekanik, dukungan hemodinamik, terapi pengganti fungsi organ, serta prioritas pelayanan sesuai kebijakan rumah sakit.

b. Konsultasi dan Persetujuan Perawatan ICU

1) Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) melakukan konsultasi dengan dokter intensivis/tim ICU mengenai indikasi perawatan intensif.
2) Tim ICU melakukan penilaian kondisi pasien berdasarkan kriteria masuk ICU.
3) Apabila pasien memenuhi kriteria masuk ICU, dilakukan koordinasi pemindahan pasien ke ICU.
4) Apabila kapasitas ICU penuh atau pasien tidak memenuhi kriteria, dilakukan keputusan alternatif sesuai kebijakan rumah sakit.
5) Pasien dan/atau keluarga diberikan edukasi mengenai kondisi pasien, rencana terapi, risiko, serta tata tertib pelayanan ICU.

c. Proses Penerimaan Pasien di ICU

Setelah pasien diterima di ICU dilakukan:

1) Serah terima pasien secara efektif menggunakan metode komunikasi SBAR.
2) Identifikasi pasien dan verifikasi kelengkapan dokumen medis.
3) Penilaian awal kondisi pasien (primary assessment dan secondary assessment).
4) Pemasangan monitoring sesuai kebutuhan:
    a) Monitoring tanda vital.
    b) Elektrokardiografi (ECG).
    c) Saturasi oksigen.
    d) Tekanan darah invasif/non invasif.
    e) Monitoring hemodinamik.
5) Penetapan diagnosis kerja dan rencana terapi intensif.
6) Penentuan kebutuhan dukungan organ:
    a) Ventilasi mekanik.
    b) Vasopressor/inotropik.
    c) Terapi pengganti ginjal.
    d) Nutrisi pasien kritis.
    e) Sedasi dan analgesia.

d. Pelaksanaan Asuhan Pasien Kritis

Pelayanan pasien ICU dilakukan secara multidisiplin melalui:

1) Pengelolaan jalan napas dan ventilasi.
2) Optimalisasi sirkulasi dan perfusi organ.
3) Pengendalian infeksi dan penerapan bundle pencegahan infeksi.
4) Manajemen nyeri, sedasi, dan delirium.
5) Pengaturan nutrisi pasien kritis.
6) Pencegahan komplikasi akibat perawatan intensif.
7) Rehabilitasi dini sesuai kondisi pasien.
8) Evaluasi respons terapi secara berkala.

Tim pelayanan ICU terdiri dari:

1) Dokter intensivis/dokter penanggung jawab ICU.
2) Dokter spesialis terkait.
3) Dokter umum ICU.

4) Perawat ICU.
5) Tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan (farmasi, nutrisionis, fisioterapis, laboratorium, radiologi).

e. Monitoring dan Evaluasi Pasien

Evaluasi pasien dilakukan secara berkala melalui:

1) Visite harian tim ICU.
2) Evaluasi klinis dan laboratorium.
3) Evaluasi kebutuhan dukungan organ.
4) Evaluasi terapi dan obat-obatan.
5) Penilaian kesiapan penghentian terapi intensif.
6) Dokumentasi perkembangan pasien dalam rekam medis.

f. Kriteria Pemindahan Keluar ICU (Discharge/Transfer)

Pasien dapat dipindahkan dari ICU apabila:

1) Kondisi klinis telah stabil.
2) Tidak lagi membutuhkan dukungan organ intensif.
3) Kebutuhan monitoring dapat dilakukan di ruang perawatan dengan tingkat pengawasan lebih rendah.
4) Terdapat rencana perawatan lanjutan yang jelas.

Sebelum transfer dilakukan:

1) Evaluasi kesiapan pasien.
2) Komunikasi dengan DPJP dan unit penerima.
3) Serah terima pasien menggunakan metode SBAR.
4) Penyampaian rencana terapi lanjutan dan kebutuhan monitoring.

g. Pelayanan Pasca ICU

Setelah pasien keluar dari ICU dilakukan:

1) Monitoring kondisi pasien di ruang perawatan.
2) Evaluasi komplikasi pasca perawatan intensif.
3) Edukasi pasien dan keluarga.
4) Dokumentasi kesinambungan pelayanan.

h. Kriteria Masuk Dan Keluar Intensive Care Unit (Icu)

1) Kriteria Masuk ICU

Pasien yang dirawat di ICU adalah pasien dengan kondisi kritis atau berisiko mengalami perburukan yang membutuhkan pemantauan intensif, intervensi segera, dan/atau dukungan fungsi organ. Keputusan masuk ICU ditentukan berdasarkan kondisi klinis pasien, kebutuhan

terapi, prioritas pelayanan, serta ketersediaan sumber daya ICU.

a) Gangguan Respirasi

Pasien dengan kondisi:

- Membutuhkan ventilasi mekanik invasif maupun non invasif.
- Gagal napas akut dengan kebutuhan oksigenasi dan ventilasi yang tidak dapat dipenuhi di ruang rawat biasa.
- Ancaman kehilangan jalan napas.
- Membutuhkan pemantauan ketat setelah tindakan airway atau prosedur anestesi berisiko tinggi.

b) Gangguan Kardiovaskular

Pasien dengan kondisi:

- Syok (septik, kardiogenik, hipovolemik, atau jenis syok lainnya) yang membutuhkan resusitasi dan pemantauan intensif.
- Membutuhkan obat vasoaktif (vasopressor/inotropik).
- Gangguan irama jantung yang mengancam nyawa.
- Henti jantung setelah dilakukan resusitasi dan memerlukan perawatan lanjutan.
- Sindrom koroner akut dengan komplikasi atau risiko tinggi.
- Membutuhkan monitoring hemodinamik invasif.

c) Gangguan Neurologis

Pasien dengan kondisi:

- Penurunan kesadaran akut.
- Koma atau membutuhkan proteksi jalan napas.
- Kejang berulang atau status epileptikus.
- Cedera otak berat.
- Stroke akut dengan kebutuhan pemantauan intensif.

d) Gangguan Metabolik dan Organ Lain

Pasien dengan kondisi:

- Gangguan metabolik berat yang membutuhkan monitoring dan terapi intensif.
- Gagal ginjal akut dengan indikasi terapi pengganti ginjal.
- Gangguan elektrolit berat dengan risiko komplikasi.
- Sepsis atau syok sepsis yang membutuhkan terapi sesuai protokol.
- Gagal multi organ.

e) Pasien Pasca Operasi dan Anestesi

Pasien yang membutuhkan perawatan ICU setelah tindakan:

- Operasi besar dengan risiko tinggi.
- Operasi dengan komplikasi intraoperatif.
- Membutuhkan ventilasi mekanik atau monitoring intensif pasca anestesi.
- Pasien dengan kondisi fisiologis tidak stabil.

f) Kriteria Berdasarkan Prioritas Pasien

Prioritas 1

- Pasien kritis yang membutuhkan terapi intensif dan dukungan organ segera, antara lain:
- Ventilasi mekanik.
- Dukungan vasoaktif.
- Resusitasi lanjutan.

Prioritas 2

- Pasien yang membutuhkan monitoring intensif dan kemungkinan intervensi segera karena risiko perburukan.

Prioritas 3

- Pasien dengan penyakit berat dan kondisi kompleks yang membutuhkan terapi intensif, namun memiliki kemungkinan keterbatasan respons terhadap terapi.

Prioritas 4

- Pasien yang tidak mendapatkan manfaat dari terapi ICU atau pasien dengan kondisi terminal

yang telah disepakati melalui keputusan medis dan komunikasi dengan keluarga.

2) Kriteria Keluar ICU

Pasien dapat dipindahkan dari ICU apabila kondisi klinis telah stabil dan tidak lagi membutuhkan pemantauan maupun terapi intensif. Keputusan keluar ICU dilakukan oleh tim ICU bersama DPJP berdasarkan evaluasi klinis menyeluruh.

a) Stabilitas Sistem Pernapasan
   - Tidak membutuhkan ventilasi mekanik invasif.
   - Kebutuhan oksigen stabil dan dapat diberikan di ruang perawatan biasa.
   - Jalan napas aman dan mampu mempertahankan ventilasi spontan.

b) Stabilitas Hemodinamik
   - Tekanan darah stabil tanpa atau dengan terapi minimal.
   - Tidak membutuhkan vasopressor/inotropik dosis tinggi.
   - Tidak terdapat tanda syok aktif.
   - Gangguan irama jantung telah terkontrol.

c) Stabilitas Neurologis
   - Tingkat kesadaran membaik dan stabil.
   - Tidak membutuhkan pemantauan neurologis intensif.
   - Kejang terkontrol.

d) Stabilitas Organ dan Metabolik
   - Tidak membutuhkan dukungan organ intensif.
   - Gangguan metabolik dan elektrolit terkoreksi atau dapat dimonitor di ruang perawatan.
   - Terapi lanjutan dapat dilakukan di unit perawatan biasa.

e) Pertimbangan Klinis Lain
   - Kebutuhan monitoring pasien telah sesuai dengan fasilitas ruang perawatan lanjutan.
   - Tersedia rencana terapi lanjutan yang jelas.

- Pasien dan keluarga telah mendapatkan edukasi terkait pemindahan perawatan.

2. Anastesi perioperatif

ALUR PELAYANAN ANESTESI DI INSTALASI BEDAH SENTRAL

a. Tahap Pra Anestesi (Pre Anesthesia Assessment)

Pelayanan anestesi dimulai dengan proses penilaian pra anestesi oleh dokter anestesiologi untuk memastikan kesiapan pasien menjalani tindakan anestesi dan pembedahan. Penilaian dilakukan sebelum operasi terjadwal maupun sebelum tindakan emergensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1) Verifikasi identitas pasien dan kesesuaian tindakan operasi.
2) Evaluasi kondisi umum pasien dan riwayat penyakit.
3) Anamnesis terkait riwayat anestesi sebelumnya, alergi obat, penggunaan obat rutin, dan faktor risiko anestesi.
4) Pemeriksaan fisik dan penilaian jalan napas (airway assessment).
5) Penilaian status fisik pasien berdasarkan ASA Physical Status Classification.
6) Evaluasi hasil pemeriksaan penunjang sesuai indikasi.
7) Penentuan teknik anestesi (umum, regional, sedasi, atau kombinasi).
8) Perencanaan manajemen jalan napas, monitoring, analgesia, dan risiko perioperatif.
9) Pemberian edukasi dan informed consent anestesi kepada pasien/keluarga.
10) Hasil penilaian dicatat dalam rekam medis anestesi sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

b. Persiapan Pasien Menuju Kamar Operasi

Sebelum pasien masuk kamar operasi dilakukan:

1) Konfirmasi kesiapan pasien melalui checklist keselamatan operasi (Surgical Safety Checklist).
2) Verifikasi informed consent tindakan operasi dan anestesi.
3) Pemeriksaan kelengkapan rekam medis dan hasil pemeriksaan penunjang.

4) Verifikasi status puasa dan persiapan khusus sesuai kondisi pasien.
5) Pemindahan pasien ke Instalasi Bedah Sentral sesuai alur transport pasien.
6) Serah terima pasien antara petugas pengirim dan petugas kamar operasi menggunakan metode komunikasi efektif SBAR.

c. Tahap Intra Anestesi (Pelaksanaan Anestesi)

Pelaksanaan anestesi dilakukan oleh tim anestesi sesuai kewenangan klinis dan standar pelayanan anestesiologi. Kegiatan meliputi:

1) Identifikasi ulang pasien dan tindakan operasi sebelum induksi anestesi.
2) Persiapan mesin anestesi, alat monitoring, obat anestesi, dan peralatan emergensi.
3) Pelaksanaan induksi anestesi sesuai rencana.
4) Pemeliharaan anestesi selama tindakan operasi.
5) Monitoring berkelanjutan terhadap:
   a) Jalan napas.
   b) Ventilasi dan oksigenasi.
   c) Sirkulasi dan hemodinamik.
   d) Kedalaman anestesi.
   e) Suhu tubuh.
   f) Cairan dan perdarahan.
6) Manajemen komplikasi anestesi apabila terjadi.
7) Dokumentasi seluruh tindakan, obat, cairan, dan parameter monitoring dalam rekam medis anestesi.

d. Tahap Pemulihan Pasca Anestesi (Recovery)

Setelah operasi selesai, pasien dilakukan evaluasi dan pemulihan pasca anestesi. Kegiatan meliputi:

1) Penghentian anestesi dan proses pemulihan kesadaran.
2) Evaluasi jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, dan nyeri.
3) Penilaian kesiapan ekstubasi apabila menggunakan ventilasi mekanik.
4) Pemindahan pasien ke Recovery Room/PACU atau ICU sesuai kondisi klinis.

5) Monitoring tanda vital dan komplikasi pasca anestesi.
6) Penilaian skor pemulihan (sesuai standar yang digunakan rumah sakit).
7) Dokumentasi kondisi pasien saat keluar dari ruang pemulihan.

e. Pemindahan Pasien Setelah Anestesi

Pasien dipindahkan berdasarkan kondisi klinis:

1) Ke Ruang Rawat Inap Apabila:
   a) Kesadaran baik.
   b) Tanda vital stabil.
   c) Nyeri terkontrol.
   d) Tidak membutuhkan monitoring intensif.
2) Ke ICU/HCU Apabila:
   a) Membutuhkan ventilasi mekanik.
   b) Membutuhkan monitoring intensif.
   c) Kondisi hemodinamik belum stabil.
   d) Terdapat risiko komplikasi tinggi.

Serah terima pasien dilakukan secara terstruktur menggunakan metode SBAR dan didokumentasikan.

f. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelayanan Anestesi

Evaluasi pelayanan anestesi dilakukan melalui:

1) Visite pasca anestesi.
2) Monitoring komplikasi pasca operasi.
3) Evaluasi manajemen nyeri.
4) Audit pelayanan anestesi.
5) Pelaporan insiden keselamatan pasien.
6) Analisis indikator mutu pelayanan anestesi.

3. NORA

a. ALUR PELAYANAN SEDASI DI LUAR KAMAR OPERASI (NON OPERATING ROOM ANESTHESIA/NORA)

1) Pengajuan Permintaan Sedasi

Pelayanan sedasi di luar kamar operasi diberikan berdasarkan indikasi medis untuk membantu pelaksanaan prosedur diagnostik maupun terapeutik yang membutuhkan kontrol nyeri, kecemasan, imobilisasi pasien, atau kondisi tertentu yang memerlukan pengelolaan jalan napas dan fungsi fisiologis. Permintaan

pelayanan sedasi diajukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dengan mencantumkan:

(a) Identitas pasien.
(b) Diagnosis dan indikasi tindakan.
(c) Jenis prosedur yang akan dilakukan.
(d) Lokasi pelaksanaan tindakan.
(e) Tingkat kedalaman sedasi yang direncanakan.
(f) Faktor risiko pasien.

Dokter anestesiologi melakukan penilaian kelayakan sedasi berdasarkan kondisi klinis pasien dan risiko tindakan.

2) Penilaian Pra Sedasi (Pre Sedation Assessment)

Sebelum tindakan sedasi dilakukan, dokter anestesiologi melakukan evaluasi meliputi:

a) Verifikasi identitas pasien dan prosedur yang akan dilakukan.
b) Anamnesis riwayat penyakit, alergi obat, obat yang dikonsumsi, dan riwayat anestesi/sedasi sebelumnya.
c) Pemeriksaan fisik meliputi:
   - Status jalan napas (airway assessment).
   - Sistem kardiovaskular.
   - Sistem respirasi.
   - Status neurologis.
d) Penilaian status fisik pasien berdasarkan ASA Physical Status Classification.
e) Evaluasi hasil pemeriksaan penunjang sesuai indikasi.
f) Penentuan tingkat kedalaman sedasi:
   - Sedasi minimal.
   - Sedasi sedang/moderat.
   - Sedasi dalam.
   - Anestesi umum bila diperlukan.
g) Penentuan rencana monitoring, obat sedasi, analgesia, dan antisipasi komplikasi.

Pasien dan/atau keluarga diberikan edukasi mengenai prosedur sedasi, risiko, alternatif tindakan, serta dilakukan persetujuan tindakan (informed consent).

3) Persiapan Pelayanan Sedasi

Sebelum sedasi dilakukan, tim memastikan kesiapan:

a) Kesiapan Pasien

(1) Identifikasi pasien sesuai standar keselamatan pasien.

- Konfirmasi informed consent.
- Evaluasi status puasa sesuai kondisi klinis dan jenis sedasi.
- Pemasangan akses intravena bila diperlukan.
- Persiapan obat dan alat monitoring.

b) Kesiapan Area Tindakan

Lokasi sedasi harus memenuhi persyaratan:

(1) Ruangan memiliki akses terhadap oksigen dan sistem penghisap.
(2) Tersedia alat monitoring standar.
(3) Tersedia peralatan pengelolaan jalan napas.
(4) Tersedia obat emergensi dan alat resusitasi.
(5) Tersedia peralatan bantuan hidup sesuai kebutuhan.

c) Kesiapan Tim

Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang kompeten sesuai tingkat sedasi, terdiri dari:

(1) Dokter anestesiologi.
(2) Perawat anestesi/tenaga kesehatan terlatih.
(3) Tim pelaksana prosedur.

4) Pelaksanaan Sedasi

Pelaksanaan sedasi dilakukan sesuai standar pelayanan anestesiologi dengan prinsip keselamatan pasien. Kegiatan meliputi:

a) Verifikasi akhir pasien, prosedur, dan lokasi tindakan (time out).
b) Pemberian obat sedasi dan analgesia sesuai rencana.
c) Monitoring berkelanjutan meliputi:

(1) Tingkat kesadaran.
(2) Frekuensi napas.
(3) Saturasi oksigen.
(4) Tekanan darah.

(5) Denyut jantung.
(6) Irama jantung sesuai indikasi.
(7) Tanda komplikasi sedasi.

d) Dokumentasi obat, dosis, waktu pemberian, parameter monitoring, dan kejadian selama tindakan. Dokter anestesiologi bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien selama periode sedasi sampai pasien memenuhi kriteria pemulihan.

5) Pemulihan Pasca Sedasi

Setelah prosedur selesai, pasien menjalani pemulihan dengan monitoring sampai efek sedasi berkurang. Evaluasi meliputi:

a) Kesadaran dan orientasi pasien.
b) Status jalan napas dan ventilasi.
c) Stabilitas hemodinamik.
d) Tingkat nyeri.
e) Mual muntah pasca tindakan.
f) Kemampuan mempertahankan fungsi fisiologis.

Pasien dinyatakan dapat dipindahkan apabila memenuhi kriteria pemulihan yang ditetapkan rumah sakit.

6) Pemulangan dan Transfer Pasien

Pasien dapat:

a) Dipulangkan dengan pendamping setelah memenuhi kriteria pemulangan.
b) Dipindahkan ke ruang rawat inap.
c) Dipindahkan ke ICU/HCU apabila membutuhkan monitoring atau terapi lanjutan.

Sebelum transfer dilakukan:

a) Edukasi pasien dan keluarga.
b) Instruksi pasca sedasi.
c) Serah terima pasien menggunakan metode komunikasi efektif SBAR bila berpindah unit.
d) Dokumentasi lengkap dalam rekam medis.

7) Dokumentasi dan Evaluasi Mutu

Seluruh pelayanan sedasi wajib didokumentasikan meliputi:

a) Asesmen pra sedasi.

b) Persetujuan tindakan.
c) Catatan pelaksanaan sedasi.
d) Monitoring selama tindakan.
e) Evaluasi pemulihan.
f) Kejadian tidak diharapkan atau komplikasi.

Evaluasi pelayanan dilakukan melalui:

a) Audit pelayanan sedasi.
b) Monitoring indikator mutu.
c) Evaluasi kejadian keselamatan pasien.
d) Review kasus komplikasi sedasi.

b. ALUR PELAYANAN POLIKLINIK NYERI (PAIN CLINIC)

1) Penerimaan dan Registrasi Pasien

Pelayanan Poliklinik Nyeri menerima pasien dengan keluhan nyeri akut maupun kronik berdasarkan rujukan dari dokter spesialis, dokter umum, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, maupun pasien yang datang sesuai ketentuan rumah sakit. Pada tahap awal dilakukan:

a) Registrasi dan verifikasi identitas pasien.
b) Verifikasi surat rujukan dan kelengkapan administrasi.
c) Penentuan prioritas pelayanan berdasarkan kondisi klinis pasien.

2) Asesmen Awal Nyeri (Pain Assessment)

Setiap pasien dilakukan asesmen nyeri secara komprehensif oleh dokter anestesiologi/konsultan nyeri atau dokter yang berwenang. Asesmen meliputi:

a) Riwayat nyeri:
   (1) Lokasi nyeri.
   (2) Awitan dan durasi nyeri.
   (3) Karakteristik nyeri.
   (4) Faktor yang memperberat dan mengurangi nyeri.
   (5) Intensitas nyeri menggunakan skala nyeri yang sesuai.
b) Penilaian dampak nyeri terhadap:
   (1) Aktivitas sehari-hari.

(2) Kualitas tidur.
(3) Fungsi fisik dan psikososial.
(4) Kualitas hidup pasien.

c) Riwayat penyakit sebelumnya.
d) Riwayat penggunaan obat analgesik dan terapi nyeri sebelumnya.
e) Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan neurologis sesuai indikasi.
f) Pemeriksaan penunjang bila diperlukan.

3) Penetapan Diagnosis dan Rencana Tata Laksana Nyeri

Berdasarkan hasil asesmen, dokter anestesiologi menentukan:

a) Diagnosis dan mekanisme nyeri:
(1) Nyeri nosiseptif.
(2) Nyeri neuropatik.
(3) Nyeri campuran.
(4) Nyeri kanker.
(5) Nyeri pasca operasi.
b) Derajat nyeri dan tingkat kompleksitas pasien.
c) Target terapi nyeri secara individual.
d) Rencana terapi dapat meliputi:
(1) Edukasi dan modifikasi gaya hidup.
(2) Terapi farmakologi analgesik multimodal.
(3) Terapi non farmakologi.
(4) Fisioterapi dan rehabilitasi medik.
(5) Tindakan intervensi nyeri bila terdapat indikasi.
(6) Konsultasi multidisiplin sesuai kebutuhan.

4) Pelaksanaan Terapi Nyeri

Pelaksanaan terapi dilakukan sesuai rencana dan standar pelayanan, meliputi:

a) Terapi Farmakologi
(1) Analgesik non opioid.
(2) Opioid sesuai indikasi dan pemantauan.
(3) Adjuvan analgesik.
(4) Penyesuaian dosis berdasarkan respons dan efek samping.
b) Terapi Intervensi Nyeri

Sesuai indikasi klinis, dapat dilakukan:

(1) Injeksi blok saraf perifer.
(2) Blok saraf regional.
(3) Injeksi epidural.
(4) Prosedur pain intervention lainnya sesuai kompetensi dan fasilitas.

c) Pendekatan Multidisiplin

Melibatkan:

(1) Dokter anestesiologi/konsultan nyeri.
(2) Dokter spesialis terkait.
(3) Rehabilitasi medik.
(4) Psikologi/psikiatri bila diperlukan.
(5) Tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan.

5) Monitoring dan Evaluasi Respons Terapi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai:

a) Perubahan intensitas nyeri.
b) Perbaikan fungsi dan aktivitas pasien.
c) Efektivitas terapi.
d) Efek samping obat.
e) Kepatuhan pasien terhadap rencana terapi.

Hasil evaluasi digunakan untuk:

a) Melanjutkan terapi.
b) Modifikasi terapi.
c) Eskalasi tindakan.
d) Rujukan atau konsultasi multidisiplin.

6) Edukasi Pasien dan Keluarga

Pasien dan keluarga diberikan edukasi mengenai:

a) Penyebab dan mekanisme nyeri.
b) Tujuan terapi nyeri.
c) Penggunaan obat yang aman.
d) Pencegahan efek samping obat.
e) Latihan atau terapi pendukung.
f) Tanda bahaya yang memerlukan evaluasi segera.

7) Tindak Lanjut (Follow Up)

Tindak lanjut dilakukan sesuai kondisi pasien dengan jadwal kontrol yang ditentukan berdasarkan:

a) Jenis dan kronisitas nyeri.

b) Respons terhadap terapi.
c) Tindakan intervensi yang dilakukan.
d) Risiko komplikasi.

Setiap kunjungan dilakukan dokumentasi:

a) Asesmen nyeri.
b) Terapi yang diberikan.
c) Respons terapi.
d) Rencana tindak lanjut.

c. ALUR PELAYANAN CODE BLUE

1) Definisi

Code Blue merupakan sistem respons cepat rumah sakit terhadap kejadian henti jantung dan/atau henti napas yang memerlukan tindakan resusitasi segera oleh tim terlatih untuk mempertahankan fungsi vital dan meningkatkan peluang keselamatan pasien. Pelaksanaan Code Blue melibatkan tim multidisiplin dengan koordinasi yang jelas, komunikasi efektif, serta penerapan prinsip Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan Bantuan Hidup Lanjut (BHL) sesuai standar yang berlaku.

2) Identifikasi Kondisi Kegawatdaruratan

Code Blue diaktifkan apabila ditemukan kondisi pasien dengan tanda:

a) Tidak sadar atau tidak memberikan respons.
b) Tidak bernapas atau napas tidak normal (agonal).
c) Tidak terdapat tanda sirkulasi efektif.
d) Henti jantung.
e) Henti napas.
f) Kondisi klinis yang mengarah pada perburukan cepat dan membutuhkan resusitasi segera.

Petugas pertama yang menemukan kejadian melakukan penilaian awal keselamatan lokasi dan kondisi pasien.

3) Aktivasi Code Blue

Apabila ditemukan kondisi kegawatdaruratan:

a) Pastikan keamanan lingkungan dan pasien.
b) Lakukan penilaian respons pasien.

c) Aktifkan sistem Code Blue melalui mekanisme rumah sakit.
d) Informasikan lokasi kejadian secara jelas.
e) Mulai tindakan resusitasi segera.

Petugas pertama melakukan:

a) Bantuan Hidup Dasar (BHD).
b) Kompresi dada berkualitas tinggi.
c) Pemberian ventilasi sesuai fasilitas yang tersedia.
d) Penggunaan Automated External Defibrillator (AED) bila tersedia.

4) Respons Tim Code Blue

Tim Code Blue menuju lokasi kejadian dengan membawa:

a) Emergency trolley/crash cart.
b) Defibrillator.
c) Peralatan airway.
d) Obat-obatan emergensi.
e) Peralatan monitoring.

Komposisi tim dapat terdiri dari:

a) Dokter anestesi/intensivis sebagai ketua tim (team leader) sesuai kebijakan rumah sakit.
b) Dokter jaga.
c) Perawat terlatih ACLS.
d) Penata anestesi/perawat anestesi.
e) Tenaga pendukung sesuai kebutuhan.

5) Pelaksanaan Resusitasi

Ketua tim melakukan koordinasi tindakan resusitasi meliputi:

A – Airway

- Evaluasi dan pengamanan jalan napas.
- Tindakan intubasi bila terdapat indikasi.

B – Breathing

- Pemberian oksigen.
- Ventilasi menggunakan bag valve mask atau ventilator.

C – Circulation

- Kompresi dada berkualitas tinggi.

- Pemasangan akses intravena/intraosseus.
- Pemberian obat resusitasi sesuai algoritme.
- Defibrilasi bila terdapat indikasi.

D – Disability

- Evaluasi status neurologis.
- Monitoring respons pasien.

E – Exposure

- Evaluasi penyebab yang dapat diperbaiki.

6) Evaluasi Ritme dan Respons Terapi

Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai algoritme resusitasi:

a) Analisis ritme jantung.
b) Penentuan kebutuhan defibrilasi.
c) Evaluasi kualitas kompresi dada.
d) Pemberian terapi sesuai penyebab yang mendasari.

Identifikasi penyebab yang dapat dikoreksi (5H dan 5T):

5H:

a) Hipovolemia.
b) Hipoksia.
c) Hidrogen ion (asidosis).
d) Hipo/hiperkalemia.
e) Hipotermia.

5T:

a) Tension pneumothorax.
b) Tamponade jantung.
c) Toksin.
d) Trombosis koroner.
e) Trombosis pulmonal.

7) Keputusan Akhir Resusitasi

Setelah dilakukan tindakan resusitasi, tim menetapkan:

a) Apabila pasien mengalami ROSC:
   (1) Stabilkan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi.
   (2) Lakukan monitoring intensif.
   (3) Evaluasi penyebab henti jantung.
   (4) Pertimbangkan perawatan ICU/HCU.
   (5) Dokumentasikan kejadian dan tindakan.
b) Apabila tidak terdapat respons terhadap resusitasi:

(1) Penghentian resusitasi dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dan kebijakan rumah sakit.
(2) Dokter menetapkan kematian secara klinis sesuai ketentuan.
(3) Dilakukan komunikasi dengan keluarga secara profesional dan empatik.

8) Pasca Code Blue

Setelah kejadian Code Blue dilakukan:

a) Dokumentasi lengkap tindakan resusitasi.
b) Pelaporan insiden keselamatan pasien bila diperlukan.
c) Debriefing tim untuk evaluasi pelaksanaan.
d) Analisis kasus dan audit klinis.
e) Evaluasi ketersediaan serta kesiapan alat emergensi.
f) Program perbaikan mutu pelayanan.

B. Jenis Pelayanan

1. General ICU merupakan pelayanan Intensif secara umum untuk pasien dewasa > 18 tahun untuk kasus pasien kritis yang memerlukan bantuan nafas, obat – obatan vasopressor, dan pengawasan intensif.
2. Unit NICU (Neonatal Intensive Care Unit) yaitu pelayanan perawatan intensif (Level III) bagi bayi baru lahir berisiko tinggi yang mengalami gangguan fungsi organ vital dengan batasan usia 0 hingga 28 hari pasca-lahir (termasuk bayi prematuritas ekstrem atau dengan berat badan lahir amat sangat rendah).
3. Unit Peristi (Neonatologi) yaitu pelayanan perawatan semi-intensif (Intermediate Care / Level II) dan perawatan risiko rendah (Low Care / Level I) bagi neonatus yang memerlukan pemantauan khusus, terapi sinar, rehabilitasi laktasi, atau masa transisi pemulihan dari kondisi kritis sebelum diizinkan pulang.
4. Unit PICU (Pediatric Intensive Care Unit) yaitu pelayanan perawatan intensif bagi pasien anak yang mengalami sakit kritis atau kegagalan fungsi organ vital yang mengancam nyawa, dengan batasan usia di atas 28 hari sampai dengan menjelang usia 18 tahun.
5. Unit anastesi perioperatif yaitu pelayanan anestesi untuk kasus operasi di Instalasi Bedah Sentral.

6. Unit ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) yaitu palayanan perawatan intensif bagi pasien dengan penyakit jantung yang memerlukan terapi intensif dan pemantauan.
7. Unit Anestesi di Luar IBS (Non Operating Room Anestesi/ NORA) yaitu pelayanan anestesi yang meliputi pelayanan kegawatan Code Blue, Manejemen Nyeri, Sedasi di Luar IBS (CT Scan, Cathlab, MRI, ECT dan Radioterapi).

C. Koordinasi

1. Koordinasi Internal

KOORDINASI DAN RUJUKAN INTERNAL RUMAH SAKIT

a. Koordinasi Pelayanan

Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan pelayanan multidisiplin yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi efektif antar unit pelayanan untuk menjamin kesinambungan asuhan pasien, keselamatan pasien, serta mutu pelayanan. Koordinasi dilakukan antara Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif dengan seluruh unit terkait melalui komunikasi terstruktur, konsultasi klinis, sistem rujukan internal, serta kolaborasi dalam pengambilan keputusan medis. Koordinasi pelayanan dilaksanakan melalui:

1) Komunikasi efektif antar tenaga kesehatan menggunakan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).
2) Konsultasi dan koordinasi antara dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), dokter anestesiologi/intensivis, dokter spesialis terkait, serta tim keperawatan.
3) Visite multidisiplin pada pasien kritis.
4) Serah terima pasien antar unit secara terstruktur.
5) Pelaksanaan diskusi kasus, audit klinis, dan evaluasi mutu pelayanan.
6) Koordinasi pelayanan kegawatdaruratan melalui sistem Code Blue rumah sakit.

b. Koordinasi Antar Unit Pelayanan

1) Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Koordinasi dilakukan pada pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan:

a) Resusitasi dan stabilisasi awal.
b) Konsultasi anestesi/intensif.
c) Perawatan ICU/ICCU/PICU/NICU.
d) Tindakan airway management, ventilasi, atau dukungan hemodinamik.

2) Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Koordinasi meliputi:

a) Konsultasi pra anestesi pasien operasi elektif maupun emergensi.
b) Perencanaan teknik anestesi dan monitoring.
c) Persiapan pasien risiko tinggi.
d) Penentuan kebutuhan perawatan pasca operasi di ICU/HCU.
e) Serah terima pasien pasca anestesi.

3) Ruang Rawat Inap

Koordinasi dilakukan pada pasien yang mengalami:

a) Perburukan kondisi klinis.
b) Kebutuhan monitoring intensif.
c) Kegagalan organ.
d) Kebutuhan ventilasi atau terapi suportif.

4) Unit Perawatan Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU)

Koordinasi antar unit intensif dilakukan untuk:

a) Transfer pasien sesuai kebutuhan usia, diagnosis, dan tingkat kompleksitas.
b) Konsultasi kasus kritis.
c) Penggunaan sumber daya bersama.
d) Penanganan pasien dengan kebutuhan multidisiplin.

Pertimbangan transfer meliputi:

a) Kondisi klinis pasien.
b) Ketersediaan tempat tidur.
c) Kompetensi dan fasilitas unit penerima.

5) Unit Penunjang

Koordinasi dilakukan dengan:

a) Instalasi Laboratorium untuk pemeriksaan penunjang dan monitoring terapi.
b) Instalasi Radiologi untuk pemeriksaan diagnostik.

c) Instalasi Farmasi untuk pengelolaan obat kritis, obat anestesi, dan obat emergensi.
d) Instalasi Gizi untuk pengelolaan nutrisi pasien kritis.
e) Rehabilitasi Medik untuk mobilisasi dan pemulihan pasien.
f) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) terkait pencegahan infeksi pelayanan intensif.

c. Rujukan Internal Rumah Sakit

Rujukan internal merupakan proses pemindahan atau konsultasi pasien antar unit pelayanan dalam rumah sakit berdasarkan kebutuhan klinis pasien dan tingkat pelayanan yang diperlukan.

1) Indikasi Rujukan Internal

Rujukan dilakukan apabila pasien:

a) Membutuhkan tingkat monitoring yang lebih tinggi.
b) Membutuhkan dukungan organ.
c) Membutuhkan pelayanan spesifik sesuai kompetensi unit.
d) Membutuhkan tindakan anestesi atau sedasi.
e) Membutuhkan perawatan intensif sesuai kondisi klinis.

d. Rujukan dari ICU ke Unit Lain

Pasien dipindahkan apabila:

1) Kondisi stabil.
2) Tidak lagi membutuhkan dukungan terapi intensif.
3) Membutuhkan pelayanan lanjutan di unit lain.

e. Rujukan Pelayanan Anestesi Non Operating Room (NORA)

Pasien yang membutuhkan sedasi/anestesi di luar kamar operasi dilakukan:

1) Permintaan dari unit terkait.
2) Assessment dokter anestesi.
3) Penilaian risiko pasien.
4) Pelaksanaan anestesi/sedasi.
5) Monitoring pasca tindakan.
6) Transfer kembali ke unit asal atau ICU sesuai kondisi.

f. Dokumentasi dan Evaluasi

Setiap proses koordinasi dan rujukan internal wajib didokumentasikan dalam rekam medis pasien, meliputi:

1) Permintaan konsultasi/rujukan.
2) Hasil evaluasi pasien.
3) Keputusan penerimaan atau pemindahan pasien.
4) Serah terima antar tenaga kesehatan.
5) Rencana terapi lanjutan.

Evaluasi pelaksanaan koordinasi dan rujukan dilakukan secara berkala melalui:

1) Audit klinis.
2) Evaluasi insiden keselamatan pasien.
3) Monitoring indikator mutu pelayanan.
4) Rapat koordinasi multidisiplin.

2. Koordinasi Eksternal

KOORDINASI DAN RUJUKAN EKSTERNAL RUMAH SAKIT

a. Koordinasi Pelayanan Eksternal

Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan pelayanan yang membutuhkan jejaring dan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan pasien, terutama pada kondisi yang membutuhkan tingkat pelayanan, fasilitas, atau kompetensi yang tidak tersedia di rumah sakit. Koordinasi eksternal dilakukan secara terencana, efektif, dan terdokumentasi dengan mengutamakan keselamatan pasien, ketepatan waktu pelayanan, serta prinsip rujukan berjenjang. Koordinasi eksternal dilakukan dengan:

1) Rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas pelayanan intensif lebih lengkap.
2) Rumah sakit jejaring pendidikan atau pusat rujukan tertentu.
3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.
4) Sistem rujukan kegawatdaruratan regional/nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung antar dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), dokter anestesiologi/ intensivis, serta tenaga kesehatan terkait

dengan menggunakan komunikasi efektif SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).

b. Indikasi Rujukan Eksternal

Rujukan eksternal dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan yang tidak dapat diberikan secara optimal di rumah sakit, antara lain:

1) Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya
   a) Tidak tersedianya fasilitas atau teknologi medis yang dibutuhkan.
   b) Keterbatasan alat dukungan organ.
   c) Keterbatasan kapasitas tempat tidur ICU/ICCU/PICU/NICU.
   d) Kebutuhan pelayanan subspesialistik tertentu.
2) Kebutuhan Pelayanan Intensif Khusus

   Pasien ICU/ICCU dapat dirujuk apabila membutuhkan:
   a) Tindakan diagnostik atau terapi lanjutan yang tidak tersedia.
   b) Dukungan organ tingkat lanjut.
   c) Intervensi kardiologi atau bedah jantung tertentu.
   d) Terapi khusus sesuai kebutuhan pasien.

   Pasien PICU/NICU dapat dirujuk apabila membutuhkan:
   a) Pelayanan intensif pediatrik/neonatal tingkat lanjut.
   b) Bedah pediatrik/neonatal khusus.
   c) Perawatan bayi dengan kondisi kompleks yang memerlukan fasilitas khusus.
3) Kebutuhan Pelayanan Anestesiologi Khusus

   Rujukan dapat dilakukan apabila pasien membutuhkan:
   a) Tindakan anestesi dengan fasilitas khusus yang tidak tersedia.
   b) Prosedur diagnostik/terapeutik kompleks.
   c) Pelayanan nyeri intervensi tingkat lanjut.

c. Proses Rujukan Eksternal

1) Penilaian dan Keputusan Rujukan
   a) Dokter DPJP bersama dokter anestesiologi/intensivis melakukan evaluasi kondisi pasien.
   b) Menentukan indikasi dan urgensi rujukan.

c) Memastikan manfaat rujukan lebih besar dibandingkan risiko transportasi pasien.
d) Melakukan komunikasi dengan rumah sakit penerima untuk memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan.

2) Persiapan Pasien Sebelum Rujukan

Sebelum dilakukan transfer pasien, dilakukan:

a) Stabilisasi kondisi pasien sesuai prinsip resusitasi.
b) Optimalisasi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi.
c) Pengamanan alat invasif dan akses vaskular.
d) Persiapan obat, cairan, dan alat emergensi selama transport.
e) Penentuan kebutuhan pendamping selama perjalanan:
   - Dokter.
   - Perawat terlatih.
   - Penata anestesi sesuai kondisi pasien.

Dokumen yang disiapkan meliputi:

a) Surat rujukan.
b) Resume medis.
c) Hasil pemeriksaan penunjang.
d) Daftar terapi dan obat yang diberikan.
e) Catatan anestesi/intensif.
f) Persetujuan pasien/keluarga sesuai ketentuan.

d. Pelaksanaan Transfer Pasien

Transfer pasien kritis dilakukan dengan prinsip:

1) Pasien dalam kondisi paling stabil sebelum keberangkatan.
2) Menggunakan alat transportasi medis yang sesuai.
3) Didampingi tenaga kesehatan kompeten.
4) Tersedia monitoring dan peralatan resusitasi selama perjalanan.
5) Komunikasi berkelanjutan dengan rumah sakit penerima.

Serah terima pasien dilakukan menggunakan metode SBAR, meliputi:

1) Kondisi klinis terkini.
2) Diagnosis utama.

3) Tindakan yang telah dilakukan.
4) Dukungan organ yang sedang diberikan.
5) Rencana terapi selanjutnya.

e. Rujukan Balik (Return Referral)

Setelah kondisi pasien stabil dan tidak lagi membutuhkan pelayanan tingkat lanjut, pasien dapat dilakukan rujuk balik sesuai mekanisme yang berlaku. Rujuk balik dilakukan dengan:

1) Komunikasi antara fasilitas kesehatan.
2) Penyampaian resume pelayanan.
3) Rencana tindak lanjut.
4) Edukasi pasien dan keluarga.

f. Dokumentasi dan Evaluasi Rujukan

Setiap proses rujukan eksternal wajib didokumentasikan meliputi:

1) Alasan rujukan.
2) Kondisi pasien sebelum transfer.
3) Rumah sakit tujuan.
4) Waktu keberangkatan dan penerimaan pasien.
5) Kondisi pasien saat diterima.
6) Kendala selama proses rujukan.

Evaluasi pelayanan rujukan dilakukan melalui:

1) Audit kasus rujukan.
2) Evaluasi keterlambatan pelayanan.
3) Evaluasi kejadian tidak diharapkan.
4) Monitoring mutu dan keselamatan pasien.

3. Koordinasi dan rujukan

a. Internal rumah sakit

1) PICU NICU Peristi

a) Tim PONEK 24 jam melakukan koordinasi aktif dan cepat antara tim dokter spesialis kebidanan (Sp.OG), dokter spesialis anak (Sp.A), Spesialis Anestesi (Sp.An/KIC), serta bidan/perawat resusitasi.

b) Kamar bersalin (VK) & kamar operasi (OK) menyiapan standby team resusitasi neonatal pada setiap tindakan persalinan/sectio caesarea berisiko tinggi.

c) Instalasi farmasi melakukan pemenuhan obat-obatan high alert, inotropik, TPN, serta vaksinasi/profilaksis dengan sistem pengawasan ketat.

d) Instalasi laboratorium & radiologi melakukann prioritas pemrosesan sampel darah *cito* dan pemeriksaan radiologi portabel di sisi tempat tidur (*bedside X-ray/usg*).

e) Tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) melakukan pengawasan berkala untuk mencegah kejadian Healthcare-Associated Infections (HAIs), seperti VAP (Ventilator-Associated Pneumonia) dan CLABSI (Central Line-Associated Bloodstream Infection).

2) ICU, HCU, ICCU

a) Tim jaga di ruangan rawat inap/IGD/VK/Code Blue melakukan koordinasi aktif dan cepat dengan dokter intensivist/jaga ICU Ketika ada pasien dengan perburukan yang memerlukan pengwasan dan Tindakan intensif di ICU, HCU, dan ICCU

b) Dokter intensivist/jaga ICU) menyiapkan tempat tidur pasien di ICU, HCU, dan ICCU beserta kelengkapan alat-alat : ventilator, laryngoscope, dan obat-obatan emergency.

c) Instalasi farmasi melakukan pemenuhan obat-obatan high alert, inotropik, TPN, serta vaksinasi/profilaksis dengan sistem pengawasan ketat.

d) Instalasi laboratorium & radiologi melakukann prioritas pemrosesan sampel darah *cito* dan pemeriksaan radiologi portabel di sisi tempat tidur (*bedside X-ray/usg*).

e) Tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) melakukan pengawasan berkala untuk mencegah kejadian Healthcare-Associated Infections (HAIs), seperti VAP (Ventilator-Associated Pneumonia) dan CLABSI (Central Line-Associated Bloodstream Infection).

3) Anestesi Perioperatif

a) Ruangan perawatan pasien melakukan konsultasi pendaftaran pasien operasi
b) Dokter anestesi melakukan kunjungan pre anestesi di ruangan rawat pasien. Penata anestesi/perawat anestesi di ruangan IBS melakukan persiapan operasi
c) Penata anestesi/perawat anestesi di ruangan IBS menyiapkan kelengkapan anestesi berupa alat-alat : ventilator, laryngoscope, dan obat-obatan emergency.
d) Instalasi farmasi melakukan pemenuhan obat-obatan high alert, inotropik, TPN, serta vaksinasi/profilaksis dengan sistem pengawasan ketat.
e) Instalasi laboratorium & radiologi melakukann prioritas pemrosesan sampel darah *cito* dan pemeriksaan radiologi portabel di sisi tempat tidur (*bedside X-ray/usg*).
f) Tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) melakukan pengawasan berkala untuk mencegah kejadian Healthcare-Associated Infections (HAIs), seperti VAP (Ventilator-Associated Pneumonia) dan CLABSI (Central Line-Associated Bloodstream Infection).

4) NORA
   a) Sedasi di ruangan non IBS
      (1) Ruangan perawatan pasien melakukan konsultasi pendaftaran pasien rencana Tindakan yang memerlukan sedasi dari anestesi.
      (2) Ruangan yang memerlukan Tindakan sedasi antar lain : cathlab, Digital Substraction Angiography, Radiologi, Radioterapi dan ECT di bangsal jiwa mendaftarkan program Tindakan
      (3) Dokter anestesi melakukan kunjungan pre anestesi dan premedikasi bila dibutuhkan
      (4) Penata/perawat anestesi menyiapkan alat dan obat-obatan yang dibutuhkan di ruang Tindakan
      (5) Dokter anestesi didampingi perawat/penata anestesi melakukan Tindakan sedasi, pemantauan dan post sedasi

(6) Pasien dapat dikembalikan ke ruangan inap setelah memenuhi syarat discharge score.

b) Code Blue

(1) Perawat jaga ruangan melakukan pengawasan terhadap kondisi pasien berdasarkan skor EWS.

(2) Apabila EWS 4-6 maka perawat jaga ruangan mengaktivasi code blue kegawatan medis dan menelpon DPJP.

(3) Dokter jaga sesuai jadwal melakukan pengawasan di ruangan yang mengaktivasi code blue kegawatan medis dengan respon time kurang dari 10 menit.

(4) Apabila EWS lebih dari 7 atau ada nilai biru maka dilakukan aktivasi code blue dengan menelpon 1111.

(5) Perawat melakukan penilaian respons pasien apabila pasien tidak responsif, maka perawat ruangan mengaktivasi code blue henti jantung, perawat ruangan melakukan kompresi/RJP sampai tim code blue datang.

(6) Tim Code Blue dengan respon time kurang 5 menit dan melakukan pengambilalihan penanganan resusitasi.

(7) Apabila pasien Kembali ke sirkulasi normal maka pasien dapat dipindakan ke ICU

c) Poli nyeri

(1) Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran

(2) Pasien menunggu antrean pemeriksaan di ruang tunggu

(3) Pasien dipanggil oleh petugas

(4) Dokter anestesi dengan fellow nyeri melakukan pemeriksaan dan Tindakan serta memberikan terapi dan edukasi

(5) Pasien melakukan pembayaran dan mengambil obat

b. Koordinasi Eksternal

1) Koordinasi Pelayanan Eksternal

Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan pelayanan yang membutuhkan jejaring dan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan pasien, terutama pada kondisi yang membutuhkan tingkat pelayanan, fasilitas, atau kompetensi yang tidak tersedia di rumah sakit. Koordinasi eksternal dilakukan secara terencana, efektif, dan terdokumentasi dengan mengutamakan keselamatan pasien, ketepatan waktu pelayanan, serta prinsip rujukan berjenjang. Koordinasi eksternal dilakukan dengan:

a) Rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas pelayanan intensif lebih lengkap.
b) Rumah sakit jejaring pendidikan atau pusat rujukan tertentu.
c) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.
d) Sistem rujukan kegawatdaruratan regional/nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung antar dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), dokter anestesiologi/intensivis, serta tenaga kesehatan terkait dengan menggunakan komunikasi efektif SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).

2) Indikasi Rujukan Eksternal

Rujukan eksternal dilakukan apabila pasien membutuhkan pelayanan yang tidak dapat diberikan secara optimal di rumah sakit, antara lain:

a) Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya
   (1) Tidak tersedianya fasilitas atau teknologi medis yang dibutuhkan.
   (2) Keterbatasan alat dukungan organ.
   (3) Keterbatasan kapasitas tempat tidur ICU/ICCU/PICU/NICU.
   (4) Kebutuhan pelayanan subspesialistik tertentu.

b) Kebutuhan Pelayanan Intensif Khusus

Pasien ICU/ICCU dapat dirujuk apabila membutuhkan:

(1) Tindakan diagnostik atau terapi lanjutan yang tidak tersedia.
(2) Dukungan organ tingkat lanjut.
(3) Intervensi kardiologi atau bedah jantung tertentu.
(4) Terapi khusus sesuai kebutuhan pasien.

Pasien PICU/NICU dapat dirujuk apabila membutuhkan:

(1) Pelayanan intensif pediatrik/neonatal tingkat lanjut.
(2) Bedah pediatrik/neonatal khusus.
(3) Perawatan bayi dengan kondisi kompleks yang memerlukan fasilitas khusus.

c) Kebutuhan Pelayanan Anestesiologi Khusus

Rujukan dapat dilakukan apabila pasien membutuhkan:

(1) Tindakan anestesi dengan fasilitas khusus yang tidak tersedia.
(2) Prosedur diagnostik/terapeutik kompleks.
(3) Pelayanan nyeri intervensi tingkat lanjut.

c. Proses Rujukan Eksternal

1) Penilaian dan Keputusan Rujukan

a) Dokter DPJP bersama dokter anestesiologi/intensivis melakukan evaluasi kondisi pasien.
b) Menentukan indikasi dan urgensi rujukan.
c) Memastikan manfaat rujukan lebih besar dibandingkan risiko transportasi pasien.
d) Melakukan komunikasi dengan rumah sakit penerima untuk memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan.

2) Persiapan Pasien Sebelum Rujukan

Sebelum dilakukan transfer pasien, dilakukan:

a) Stabilisasi kondisi pasien sesuai prinsip resusitasi.
b) Optimalisasi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi.
c) Pengamanan alat invasif dan akses vaskular.

d) Persiapan obat, cairan, dan alat emergensi selama transport.
e) Penentuan kebutuhan pendamping selama perjalanan:
    - Dokter.
    - Perawat terlatih.
    - Penata anestesi sesuai kondisi pasien.

Dokumen yang disiapkan meliputi:

a) Surat rujukan.
b) Resume medis.
c) Hasil pemeriksaan penunjang.
d) Daftar terapi dan obat yang diberikan.
e) Catatan anestesi/intensif.
f) Persetujuan pasien/keluarga sesuai ketentuan.

3) Pelaksanaan Transfer Pasien

Transfer pasien kritis dilakukan dengan prinsip:

a) Pasien dalam kondisi paling stabil sebelum keberangkatan.
b) Menggunakan alat transportasi medis yang sesuai.
c) Didampingi tenaga kesehatan kompeten.
d) Tersedia monitoring dan peralatan resusitasi selama perjalanan.
e) Komunikasi berkelanjutan dengan rumah sakit penerima.

Serah terima pasien dilakukan menggunakan metode SBAR, meliputi:

a) Kondisi klinis terkini.
b) Diagnosis utama.
c) Tindakan yang telah dilakukan.
d) Dukungan organ yang sedang diberikan.
e) Rencana terapi selanjutnya.

d. Rujukan Balik (Return Referral)

Setelah kondisi pasien stabil dan tidak lagi membutuhkan pelayanan tingkat lanjut, pasien dapat dilakukan rujuk balik sesuai mekanisme yang berlaku. Rujuk balik dilakukan dengan:

1) Komunikasi antara fasilitas kesehatan.

2) Penyampaian resume pelayanan.
3) Rencana tindak lanjut.
4) Edukasi pasien dan keluarga.

e. Dokumentasi dan Evaluasi Rujukan

Setiap proses rujukan eksternal wajib didokumentasikan meliputi:

1) Alasan rujukan.
2) Kondisi pasien sebelum transfer.
3) Rumah sakit tujuan.
4) Waktu keberangkatan dan penerimaan pasien.
5) Kondisi pasien saat diterima.
6) Kendala selama proses rujukan.

Evaluasi pelayanan rujukan dilakukan melalui:

1) Audit kasus rujukan.
2) Evaluasi keterlambatan pelayanan.
3) Evaluasi kejadian tidak diharapkan.
4) Monitoring mutu dan keselamatan pasien.

BAB V
STANDAR PENGENDALIAN INTERNAL

A. Kepatuhan regulasi

Pengendalian internal menjamin seluruh operasional unit berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku:

1. Pemenuhan legalitas dan STR/SIP Tenaga Kesehatan
   a. Seluruh dokter spesialis (Sp.A, Sp.An/KIC, Sp.Jp,), Perawat, dan perawat di unit PICU/NICU/Peristi , ICU, ICCU, IBS, NORA, wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) yang aktif.
   b. Sertifikasi kompetensi wajib bagi staf yaitu pediatric advanced life support (PALS), ATLS, ACLS, FCCS, neonatal resuscitation program (NRP/PPGDN), serta pelatihan perawat intensif.
2. Kepatuhan pada Pedoman Nasional & SPO Rumah Sakit
   a. Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) medis berbasis PNPK Anestesiologi & Terapi Intensif 2022 dan Pedoman PONEK 2025.
   b. Evaluasi berkala terhadap panduan praktik klinis (PPK) dan clinical pathway (CP) untuk kasus-kasus prioritas kanker, jantung, stroke, uronefro, tb paru, maternal, asfiksia neonatorum, BBLR/BBLSR, RDS/sepsis neonatorum, syok septik pediatrik, dan gagal napas akut.
3. Tata Kelola peralatan medis & kelayakan Fasilitas
   a. Pengujian dan kalibrasi alat medis (ventilator, transport incubator, radiant warmer, syringe/infuse pump, bedside monitor) secara berkala minimal 1 tahun sekali.
   b. Kepatuhan terhadap ambang batas proteksi radiasi dan keamanan alat medis berisiko tinggi.
4. Integrasi sistem rujukan jejaring (SISRUTE):
   Pelaksanaan alur rujukan keluar/masuk wajib tercatat secara real-time pada aplikasi SISRUTE sesuai petunjuk teknis.

B. Indikator mutu unit

Penetapan dan evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM) dan Indikator Mutu Unit masing-masing sesuai panduan.

C. Keselamatan pasien

Penerapan 6 Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) secara ketat di area intensif dan risiko tinggi

1. SKP 1: ketepatan identifikasi pasien
   a. Penggunaan dua penanda identitas (nama lengkap dan tanggal lahir) pada gelang identitas (merah muda untuk perempuan, biru untuk laki-laki, kuning untuk risiko jatuh, merah untuk alergi).
   b. Verifikasi ganda wajib dilakukan sebelum pemberian obat, pengambilan sampel darah, transfusi darah, dan tindakan invasif.
2. SKP 2 : peningkatan komunikasi efektif

   Penerapan metode SBAR (situation, background, assessment, recommendation) dan TBAK (tulis, baca, konfirmasi) saat pelaporan kondisi kritis via telepon atau serah terima (handover) shift.
3. SKP 3: peningkatan keamanan obat *high-alert*
   a. Penyimpanan terpisah untuk obat-obatan high-alert dan look-alike sound-alike (LASA) dengan penandaan stiker khusus secara jelas.
   b. Penerapan prosedur double-check oleh dua perawat sebelum pemberian dosis obat inotropik, insulin, elektrolit pekat, dan sedasi pada bayi/anak.
4. SKP 4 : kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien cermin operasi/tindakan

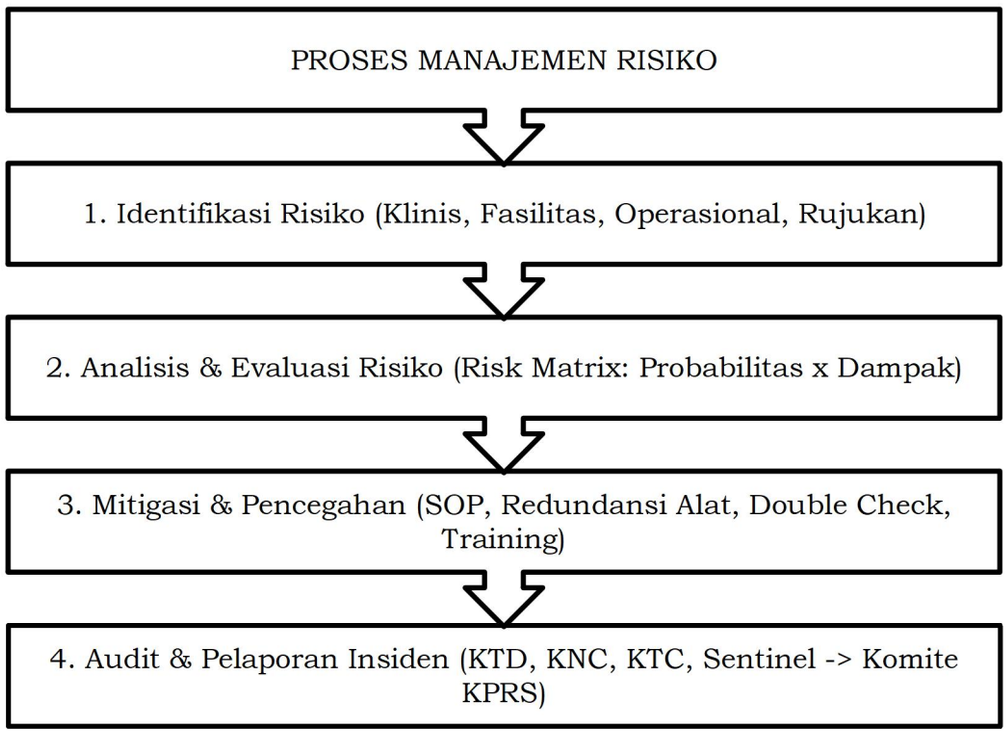
   Verifikasi checklist keselamatan tindakan invasif (bedside procedure checklist) sebelum tindakan seperti intubasi, pemasangan kateter umbilikal, atau chest tube.
5. SKP 5: pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan (hais)
   a. Kepatuhan ketat pada *bundle prevention HAIs*:
      1) Bundle VAP (ventilator-associated pneumonia)
      2) Bundle CLABSI (central line-associated bloodstream infection)
      3) Bundle ISK (infeksi saluran kemih)
   b. Pembatasan dan penataan alur pengunjung

6. SKP 6: pengurangan risiko pasien jatuh

   Penilaian risiko jatuh menggunakan skala Risiko jatuh.

D. Manajemen Risiko

Pengendalian internal berbasis manajemen risiko (Risk-Based Internal Control) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi potensi bahaya:



1. Identifikasi & mitigasi area risiko tinggi:
   a. Risiko klinis antara lain extubasi yang tidak direncanakan (*unplanned extubation*), salah dosis obat pediatrik/neonatal (*medication errors*), hipotermia pada BBLR saat transfer.
   b. Risiko fasilitas seperti kegagalan pasokan listrik/oksigen sentral, kerusakan ventilator mendadak, malfungsi inkubator.
   c. Risiko operasional seperti keterlambatan respon laboratorium/radiologi *cito*, keterbatasan tempat tidur intensif (*overcapacity*).
2. Prosedur pengendalian & pencegahan
   a. Penyediaan UPS (uninterruptible power supply) dan tabung oksigen cadangan (*backup*) di setiap bed intensif.
   b. Pembuatan tabel dosis standar obat gawat darurat pediatrik/neonatal di ruang resusitasi.
   c. Evaluasi berkala kriteria masuk dan keluar unit intensif agar tidak terjadi overcapacity.

3. Pelaporan insiden keselamatan pasien
    a. Setiap kejadian kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian tidak cedera (KTC), maupun kejadian sentinel wajib dilaporkan ke komite keselamatan pasien RS dalam waktu 1 x 24 jam
    b. Pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP) dan audit kematian anak secara rutin untuk perbaikan sistem (Root Cause Analysis / RCA).

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. Dokumentasi

Dokumentasi medis dan keperawatan di unit intensif/khusus bersifat legal, berkesinambungan, dan terintegrasi melalui Rekam medis elektronik (RME) maupun formulir medis terstandar.

1. Dokumentasi asesmen & pelayanan medis
   a. Asesmen Awal Pasien Kritis:
      1) Pengisian formulir triase dan skoring pews (pediatric early warning system) untuk anak atau nrp / stable untuk neonatus saat tiba di unit.
      2) Asesmen medis lengkap oleh DPJP (spesialis anak / anestesi intensivis) yang diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pasien masuk.
   b. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT):
      Pencatatan harian dengan metode SOAP (subjektif, objektif, asesmen, plan) yang dilakukan secara kolaboratif oleh DPJP, perawat intensif, farmasi klinis, dan ahli gizi.
   c. Lembar Observasi Intensif (*Intensive Care Flowsheet*)
      Pencatatan berkala setiap jam yang mencakup:
      1) Parameter tanda vital (frekuensi nadi, laju napas, tekanan darah, suhu, *SpO2*).
      2) Bantuan respirasi (mode pemberian 02 , spontan denagn nasal ,nrm atau ventilator, FiO2, *PEEP*, *inspiratory pressure*).
      3) Pemantauan hemodinamik & skor kesadaran (GCS).
      4) Titrasi obat-obatan inotropik, sedasi, dan analgetik dan tindakan lain.
      5) Balans cairan ketat (*fluid balance*) kumulatif per 24 jam (masukan parenteral/enteral vs keluaran urin, OGT, *IWL*)
      6) Pemasangan alat invasif dan INOS (IV line , ET , NGT , DC ,TT dan kejadian inos)
      7) Proses Keperawatan
2. Dokumentasi keselamatan pasien & prosedur invasif

a. Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) antara lain dokumentasi tertulis persetujuan/penolakan tindakan invasif (intubasi, CVC, kateter umbilikal, *chest tube*, transfusi darah).
b. Checklist bundle hais: lembar pemantauan harian kepatuhan bundle *VAP*, bundle *CLABSI*, dan bundle ISK.
c. Formulir transfer pasien meliputi form serah terima (*handover*) berbasis metode SBAR untuk transfer internal (antar-unit RS) maupun transfer eksternal.

3. Dokumentasi operasional & sarana prasarana
   a. Logbook kalibrasi & pemeliharaan alat meliputi pencatatan kondisi teknis dan jadwal kalibrasi ventilator, transport incubator, radiant warmer, syringe/infuse pump, dan bedside monitor.
   b. Suhu & kelembaban ruangan: pemantauan suhu lingkungan (22 – 24ºc) derajat serta suhu inkubator secara rutin per shift.
   c. rantai dingin (*cold chain*): lembar kontrol suhu penyimpanan obat *high-alert*, vaksin, dan ASI perah.

B. Pelaporan

Sistem pelaporan berjenjang disusun untuk mendukung akuntabilitas pelayanan, evaluasi kinerja unit.

1. Pelaporan Bulanan

   Disusun oleh kepala ruang dan ketua tim medis ICU, ICCU, NORA, Anestesi Perioperatif, PICU/NICU/Peristi paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada bidang pelayanan medis & keperawatan

   a. Laporan kinerja pelayanan & sensus harian
      1) Jumlah pasien masuk, 400.7.3.4/321/2026 dipindahkan (*step-down*), pulang sembuh, rujuk balik, dan meninggal dunia (< 24 jam ,< 48 jam dan > 48 jam).
      2) Indikator efisiensi tempat tidur meliputi bed occupancy rate (BOR), length of stay (LOS), dan turn over interval (TOI) unit PICU, NICU, dan Peristi.
   b. Laporan indikator mutu unit (INM & IMAK) meliputi :
      1) Ketidakmampuan menangani BBLR 1500-2500gr
      2) Kepatuhan waktu visite dokter
      3) Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh

4) Kepatuhan identifikasi pasie
5) Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)
6) Infeksi Luka Infus (ILI / Plebitis)
7) Dilakukan penilaian usaha napas pada bayi baru lahir
8) Dilakukan penilaian APGAR score (menit ke-1 hingga menit ke -5)
9) Dilakukan VTP sebelum usia 1 menit (60 detik)
10) Dilakukan pemberian alat bantu napas dengan ventilator, kecuali bayi yang bernapas spontan
11) Tidak ada kejadian HIE (hypoxic ischaemic encephalopathy) dari pemeriksaan skoring thomson
12) Bayi tidak meninggal akibat asfiksia

c. Laporan terlaksana sesuai target yang pelaporan terintegrasi dengan PMKP
1) Laporan surveillance infeksi rs (hais) yaitu data kejadian VAP, CLABSI, phlebitis, dan isk yang terintegrasi dengan komite PPI.
2) Laporan insiden keselamatan pasien (IKP) meliputi rekapitulasi kejadian tidak diharapkan (KTD), Kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian tidak cedera (KTC), dan kejadian sentinel.

2. Pelaporan Triwulan (3 bulanan)

Disampaikan kepada direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dan komite mutu:

a. Analisis trend & capaian indikator mutu yaitu evaluasi capaian mutu antar-bulan serta pemenuhan standar kriteria RS Kelas B.
b. Laporan audit klinis & audit kematian yaitu rekapitulasi pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP) dan audit kematian anak bersama tim PONEK RS.
c. Laporan kinerja sisrute evaluasi jumlah rujukan masuk (dari RS Tipe C/FKTP) dan rujukan keluar (ke RS pengampu utama/tersier) serta kendala sistem rujukan.
d. Laporan pemeliharaan & sarpras yaitu evaluasi kelayakan, kalibrasi, serta proyeksi kebutuhan pemeliharaan alat medis intensif.

3. Pelaporan tahunan

Disusun sebagai bahan evaluasi kinerja rumah sakit serta pelaporan eksternal ke kementerian kesehatan / dinas kesehatan

a. Evaluasi pelayanan meliputi rekapitulasi capaian indikator kinerja utama (IKU) pelayanan anestesi dan terapi intensif di RS Kelas B.
b. Laporan angka kematian meliputi *calculation gross mortality rate* (gmr) dan *net mortality rate* (nmr), gross death rate (GDR) dan net death rate (NDR)
c. Rekomendasi rencana kerja & anggaran (RKA)meliputi perencanaan kebutuhan ketenagakerjaan (pelatihan) dan peremajaan sarana/alat medis tahun anggaran berikutnya.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus PDSA (*Plan - Do - Study - Act*) untuk mendorong perbaikan mutu

BAB VII
KESIMPULAN

Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif sebagai unsur pelaksana pelayanan di RS kelas B memiliki peran strategis dalam menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelayanan anestesiologi dan terapi intensif di RSUD dr. LOEKMONO HADI dilaksanakan melalui alur yang sistematis mulai dari unit ICU, PICU NICU, ICCU, Anestesi Perioperatif dan NORA, meliputi tahap persiapan, monitoring, hingga evaluasi dan pelaporan. Standar Pengendalian Internal diterapkan pada 4 pilar utama yaitu Kepatuhan Regulasi, Indikator Mutu Unit, Keselamatan Pasien, dan Manajemen Risiko untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan program. Keberhasilan pelaksanaan di instalasi anestesiologi dan terapi intensif sangat ditentukan oleh sinergi antara Unit di RS dengan berpedoman pada visi misi Rumah Sakit. Pelaporan kegiatan secara bulanan, triwulan, dan tahunan menjadi instrumen penting untuk monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

BAB VIII
PENUTUP

Buku Pedoman Pelayanan Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas hospitalia dan unit terkait dalam menyelenggarakan pelayanan yang bermutu di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi. Dengan adanya pedoman ini diharapkan:

1. Hak dan kewajiban pasien dan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.RS mampu menjamin mutu dan keselamatan pasien.
2. Pedoman ini bersifat dinamis dan akan ditinjau ulang 2 tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah, Kemenkes, dan Akreditasi RS.

Akhir kata, mari kita wujudkan RSUD dr. Loekmono Hadi sebagai Rumah Sakit yang Unggul, Humanis, dan Berdaya Saing melalui pelayanan yang bermutu.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Februari 2026

Plt. DIREKTUR RSUD dr. LOEKMONO HADI
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RSUD dr. LOEKMONO HADI

MUSTIKO WIBOWO